

Samverkan

**Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med
dubbeldiagnos**

ABSTRACT

Växjö universitet
Institutionen för pedagogik
*Pedagogik med inriktning mot ungdoms –
och missbrukarvård, C- uppsats 10 p*

Titel	Samverkan. Professionellas åsikter om sina roller i arbetet kring personer med dubbeldiagnos.
Eng. Titel	Co-operation. Professionals opinions concerning their roles and work with people with dual diagnoses.
Författare	Peter Fornander och Jonas Jonsson
Handledare	Stellan Jeppsson
Datum	Mars 2006
Antal sidor	39
Nyckelord	Missbruk, psykisk ohälsa, samverkan, psykiatri, socialtjänst, behandlingshem.

Sammanfattning

De flesta missbrukare i vårt samhälle lider även av psykisk ohälsa. Undersökningens syfte var att skapa förståelse och kunskap om hur personal inom socialtjänst, psykiatri och behandlingshem uppfattar arbetet, de olika rollerna och samverkan i behandling av dessa individer. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen låg som grund för studien och semistrukturerade intervjuer användes som undersökningsmetod. I litteraturdelen behandlades bl.a. förklaringsmodeller till och förekomst av dubbeldiagnos samt behandlingsmodeller. I resultatet framkom att vilja till samarbete mellan de tre aktörerna finns, men mer samarbete finns att önska. De främsta hindren till välfungerande samarbete bottnar i olika traditioner och synsätt vilka orsakas främst av brister i kommunikation och dialog på organisatorisk nivå. Dessa brister syns även bland personalen närmast klienten. Samarbete som visat sig fungera bygger på samverkan kring individens hela livssituation. Långsiktighet, kontinuitet och helhet i behandling av missbrukare med psykisk ohälsa är nödvändigt.

Innehållsförteckning

Inledning	1
Bakgrund	2
Missbruk och psykisk ohälsa	2
Förklaringsmodeller	2
Gemensamma faktorsmodellen	3
Sekundära missbruksmodeller	4
Psykosociala riskfaktorsmodellen	4
Supersensitivitetsmodellen	4
Ångest och depressioner	5
Förekomst	5
Sammanfattning	6
Behandling	6
Case Management och Assertive Community Treatment (ACT)	6
Helhet och Kontinuitet	7
Socialt stöd	8
Effekter på behandlare och organisation	8
Syfte och frågeställning	9
Teoretiska utgångspunkter	10
Meads teori om mänskliga samspel	10
Antonovskys salutogena modell	11
Habermas kommunikationsteori	12
Metodologiska utgångspunkter	13
Olika forskningstraditioner	13
Kvalitativ metod	13
Val av metod	14
Intervju som datainsamlingsmetod	14
Analys och tolkning	14
Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet	15
Vår förförståelse	16
Upplägg	16
Förberedelser	16
Urval	16
Genomförande, analys och tolkning	16
Forskningsetiska överväganden	17
Resultat	18
Inledning	18
Presentation av intervjupersoner	18

Gemensam uppfattning	19
Förekomst	19
Orsak	19
Drogval kopplat till speciell problematik.....	20
Olika traditioner	20
Helheten som mål	21
Delar av en helhet som mål.....	22
Samverkan	23
Det börjar bli bättre	23
Mer finns att önska	24
Vad hindrar samverkan?	25
Ekonomi och organisation hindrar samverkan.....	25
Kortsiktighet	27
Kollision i synen på missbruk	28
Vill inte psykiatrin ha med missbrukare att göra?	28
Inte heller med behandlingshem?	28
Piller som lösning	29
Svår psykisk sjukdom, svår för vem?.....	29
Är sekretess ett hinder?	30
Teoretisk problematisering	30
Diskussion	32
Metoddiskussion	32
Resultatdiskussion.....	33
Har psykiatrin skygglappar?	33
Orsaker till samsjuklighet och stigmatisering	34
De förstår inte varandra	35
Steg i rätt riktning	36
Referenslista	38
 Bilaga 1.....	Antisocial personlighetsstörning
 Bilaga 2.....	Tillägg Socialtjänstlagen
 Bilaga 3.....	Intervjuguide
 Bilaga 4.....	Brev till intervjupersoner

Inledning

*För exakt ett år sedan ringde jag till beroendeenheten och bad om hjälp för mitt missbruk. I ett år har jag skrikit efter hjälp men fått sitta hemma och kämpa ensam mot drogerna. Jag har missbrukat droger sedan jag var elva år, idag är jag tjugotvå och fast i ett allvarligt blandmissbruk som förtär mig och min kropp, förstör mitt liv och sårar alla runt om kring mig. Elva år av mitt liv har försvunnit i en drogdimma och nu vill jag förändra det. Jag vill ha en tolvstegsbehandling i slutenvården. Men eftersom jag har en dubbeldiagnos, alltså är både drogmissbrukare och psykiskt sjuk, så vill ingen hjälpa mig. Missbruksvården hänvisar mig till psykiatri och psykiatri säger att de inte kan hjälpa mig eftersom jag missbrukar droger. Finns det ingen hjälp för oss med dubbeldiagnoser? Har vi ingen rättighet att få hjälp med att leva ett värdigt liv?
Berny Pålsson (Aftonbladet 2005-10-17)*

Enligt Jansson och Fridell (2002) är den totala vårdkonsumtionen hos missbrukare sannolikt ca 10 gånger högre än genomsnittet av övrig befolkning, en siffra som även stöds av internationell forskning. Dessvärre uteblir ofta effekterna av vård och behandling pga. avbruten mediciner, brutna avtal och återfall i missbruk. Situationen förvärras än mer för många missbrukare av personlighetsrelaterade problem. Här talar författarna om livsstilssjukdom, vilket man menar är en komplext sammansatt problematik snarare än isolerade sjukdomsbilder.

Gerdner och Sundin (1998) menar att missbrukare med psykisk ohälsa inte fått den psykiatriska hjälp eller adekvata missbruksbehandling de varit i behov av. En orsak till detta kan vara att de professionella på olika områden har haft en kamp om rätten till tolkningsföreträde. Psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter har kunskap rörande psykiska och känslomässiga störningar. Socionomer har kunskap om sociala missförhållanden, alkohol/drogbehandlare om missbruksproblematik. Denna kamp har inneburit att de klienter som fått psykiatrisk hjälp inte haft möjlighet att ta till sig insatsen pga. sin missbruksproblematik. Likaså har de som behandlats för sitt missbruk tagit återfall pga. sin psykiska ohälsa, (Gerdner & Sundin 1998).

Finns det ingen hjälp för oss med dubbeldiagnos? frågar Berny i inledningen. I media och allmänna samhällsdebatten framställs ofta problematiken kring dessa människor. Det talas om att de faller mellan stolarna, de hör inte hemma vare sig i missbruksvård eller inom psykiatri. Vår uppfattning är att det i vårt välutvecklade samhälle borde finnas både kompetens och möjligheter att bedriva vård som är anpassad efter dessa personers behov. Ur behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi det vara av stor vikt att belysa problematiken och möjligheterna på området, för att om möjligt ge svar på Bernys fråga.

Vår avsikt med denna studie är därför att genom litteraturen undersöka förekomsten av psykisk ohälsa bland missbrukare, redogöra och fördjupa oss i olika orsaksförklaringar samt behandlingsmodeller. Genom intervjuer har vi undersökt hur man arbetar med dubbeldiagnosproblematiken inom behandlingshem, psykiatri och socialtjänst samt belyst vilka roller de har i vården. Vi har också undersökt hur samverkan ser ut mellan dem och vilka faktorer som påverkar detta.

Bakgrund

Missbruk och psykisk ohälsa

Förklaringsmodeller

Begreppet dubbeldiagnos infördes under 1990- talet. Studier började då visa att missbruk och psykisk ohälsa ofta sågs som separata delar, att man hos missbrukare inte längre enbart såg psykisk ohälsa som ett känslomässigt problem orsakat av missbrukets negativa effekter (Öjehagen I: Gerdner & Sundin (red) 1998).

Frågan om vilket som kommer först, missbruket eller psykisk störning, kan ses på flera sätt. Antingen har missbruket lett till den psykiska störningen eller vice versa. Ett annat sätt att se på saken är att det finns bakgrundsfaktorer som ökar sårbarheten både för missbruket och också den psykiska störningen. Dessa tillstånd integreras och förstärker varandra växelvis. De flesta undersökningarna har dock visat att psykisk störning föregår missbruket och detta syns tydligast hos kvinnor (Öjehagen I: Gerdner & Sundin (red) 1998).

Vi har valt att använda oss av begreppet dubbeldiagnos i vår text. Orsaken är att detta begrepp fortfarande är vanligast även om andra begrepp som samsjuklighet och multipla diagnoser är mer rättvisande eftersom problembilden oftast är mer komplex än två diagnoser.

När vi i texten använder ordet missbruk syftar vi på missbruk av droger som exempelvis alkohol och narkotika. Med begreppen svår psykisk störning eller sjukdom menar vi schizofreni och manodepressiv sjukdom, som sammanfattas som symptomdiagnoser under Axel I i DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), vilket även ångestsyndrom och depression gör. Personlighetsstörningar, där bland annat antisocialpersonlighetsstörning (Se bilaga 1) ingår, beskrivs under Axel II i DSM IV. Då begreppet psykisk ohälsa används i texten används det som ett samlingsnamn för ovanstående diagnoser.

Jansson och Fridell (2002) menar att psykiska störningar sällan är den direkta orsaken till missbruk och livsstilproblem. Den psykiska störningen gör individen mer sårbar och mindre rustad att hantera och bemästra negativa konsekvenser orsakade av både livsstil och missbruk. Däremot kan missbruket orsaka uppkomst av vissa psykiska störningar och oftast förvärras psykiska störningar av missbruk. Här blir ångest och depressionssymtom tydligare under perioder av drogfrihet. Författarna menar att missbruket ofta föregås av allvarliga psykosociala problem och psykisk instabilitet under uppväxten, där instabila relationer i familjesituationen har större negativ effekt för utvecklingen hos flickor än hos pojkar. De psykosociala problemen leder ofta senare till psykisk ohälsa. Missbrukare lever ofta nära till misslyckanden och återfall och i dessa fall är ångest och depression stora riskfaktorer som ytterligare försvagar deras situation (Jansson & Fridell 2002).

Missbruk är i högre grad förekommande hos människor som lider av allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni och manodepressiv sjukdom, men varför är ännu inte klart. Många teorier om sambanden mellan psykisk sjukdom och missbruk har sett dagens ljus, men inga användbara uppgifter om ordningsföljden i debuten mellan de båda har framkommit. Det finns en mängd olika förklaringsmodeller till dubbelsjuklighet och Meuser, Drake, Wallach, Kavanagh, McFadden, McHugo, Bond, Noordsy och Fox (2001) belyser här främst fyra huvudgrupper:

- **Gemensamma faktorsmodellen** tar sin utgångspunkt i delad sårbarhet, där genetiska, ärftliga och psykosociala orsaker anses gemensamma för både missbruk och psykisk sjukdom. Även antisocial personlighetsstörning anses kunna kopplas som orsak till både missbruk och psykisk sjukdom.
- **Sekundära missbruksmodeller** menar att allvarlig psykisk sjukdom ökar risken för utvecklande av missbruk.
- **Sekundära psykiska sjukdomsmodellen** anser tvärtom, att risken för psykisk sjukdom förhöjs av missbruk.
- **Interaktionsmodellen** utgår från att båda diagnoserna ökar sårbarheten för varandra.

Vi kommer nedan endast beröra de två första av de fyra modellerna, eftersom bevisföringen inom forskningen enligt Meuser m.fl. (2001) inte ger större relevans åt de övriga teorierna som troliga förklaringsmodeller till dubbelsjuklighet. Detta styrks även av bl.a. Öjehagen och Sigvardsson (I: Gerdner & Sundin (red) 1998).

Gemensamma faktorsmodellen

Grundidén i denna teori är delad sårbarhet för både missbruk och psykisk sjukdom. Modellen bygger på ärftliga genetiska belastningar och psykosociala orsaksfaktorer, där turbulenta och svåra uppväxtmiljöer och tidiga störningar kan leda till psykisk ohälsa och missbruk senare i livet. Ofta förknippas detta med Typ II alkoholism, dvs. familjär eller mansbunden alkoholism, som är mest förekommande bland män och har en tidig debutålder. Denna typ som är starkt genetiskt betingad med nio gånger högre risk att bli alkoholist, åtföljs ofta av svåra sociala problem, kriminalitet och blandmissbruk. Denna typ har genom sitt lustsökande, spänningssökande, impulsivitet, aggressivitet och undvikande av monotoni stora likheter med antisocial personlighetsstörning, enligt studier gjorda av Hallman, von Knorring och Orland (1996 I: Melin & Näsholm 1998)

Antisocial personlighetsstörning är en riskfaktor som har kopplingar till missbruk och svår psykisk sjukdom menar Meuser m.fl. (2001). Forskningen har visat att uppförandestörning och beteendestörning i barndomen som yttrar sig i bl.a. aggressiva beteenden, lögner, skolk, undanflykter, snatteri osv. senare i livet kan övergå i antisocial personlighetsstörning. Beteendestörning under barndomen har också visat sig ha koppling till schizofreni och till viss del manodepressiv sjukdom i vuxen ålder (Toupin & Coté, 1996 I: Meuser m.fl. 2001). Enligt forskarna finns alltså länkar mellan beteendestörning i barndomen, antisocial personlighetsstörning och svår psykisk sjukdom, men även till allvarligt missbruk.

Drivkraften i missbruket anses vara både den psykiska smärtan och den impulsivitet som finns hos dessa personer. Ofta leder störningen till utåtagerande och självcentrerat beteende/tankegångar vilket skapar behov av att manipulera och styra sin omgivning i egna syften. Detta kan orsaka svårigheter i behandling eftersom det blir svårare att upprätta sunda, tillitsfulla arbetsallianser pga. klientens ofta defensiva hållning (Watkins, Lewellen & Barrett, 2000).

Kritikerna menar att kopplingen mellan antisocial personlighetsstörning och missbruk kompliceras av att missbruket i sig kan framkalla symtom liknande antisocial personlighetsstörning. Meuser m.fl. (2001) menar att denna kritik inte är relevant, eftersom man i jämförande studier klart visat att personer med fullt utvecklad antisocial personlighetsstörning med föregående beteendestörning löper större risk att hamna i missbruk

än personer utan dessa störningar. Den antisociala personlighetsstörningen, som anses stå för högst frekvens hos människor som lider av dubbelsjuklighet, försvårar missbruksförloppet och ger större negativa konsekvenser, med lägre debutålder, allvarigare sociala, rättsliga och fysiska följder. Dessutom finns tecken som tyder på att låg socioekonomisk status, låg intelligens och koncentrationssvårigheter kan öka riskerna för utvecklande av både missbruk och schizofreni (Meuser m.fl. 2001).

Sekundära missbruksmodeller

Inom de sekundära missbruksmodellerna anses den psykiska sjukdomen öka sårbarheten för missbruk. Modellerna i detta avsnitt bygger på idén om psykosociala och psykobiologiska orsaker till dubbla sjukdomstillstånd. De psykosociala riskfaktorerna kan delas upp i självmedicinering, dysforilindring och multipla riskfaktorer. Supersensitivitet som orsak anses vara av psykobiologisk natur.

Psykosociala riskfaktorsmodellen

Tanken om självmedicinering bygger på den enskilda individens medvetenhet om sin diagnos och valet av drog med hänsyn till dess psykofarmakologiska effekter, där syftet är lindring av specifika svåra känslöstämningar. Meuser m.fl. (2001) menar att drogvalet hos psykiskt sjuka personer inte går att koppla till specifika diagnoser eller inre tillstånd, utan är beroende av tillgång, umgänge och marknadskrafter. Även om de första upplevelserna av drogen och de positiva effekterna bevisligen finns i minnet hos missbrukaren, saknas bevisföring nog för idén om självmedicinering. Däremot finns inom forskningen en mer allmän uppfattning om dysforilindring. Man menar att människor med svår psykisk sjukdom ofta lider av dysfori med stor blandning av känslor av olust såsom ångest, depression, känsla av leda och ensamhet. Syftet blir att med hjälp av olika psykoaktiva substanser försöka minska olustkänslor och bättra på måendet (Leshner 1998 I: Meuser m.fl. 2001). I gjorda självrapporteringsstudier visar dubbeldiagnospatienter på användning av olika droger, som förväntad lindring för dysfori, sömnproblem, sociala bekymmer, depressioner och ångest osv. som på olika sätt ingår i de flesta diagnoser (Addington & Duckak, 1997 I: Meuser m.fl. 2001).

Inom dysforilindringshypotesen finns också uppfattningar om s.k. multipla riskfaktorer för missbruk som består av social karaktär. Exempel på detta är social isolering, brister i kognitiva och relationella förmågor, misslyckanden i yrkesliv och privat liv m.m. Ytterligare faktorer kan vara tillgång till droger och motivationen av samvaro med avvikande grupper, där droger och alkohol ses som naturlig del av tillvaron. Inom forskningen finns få bevis som styrker denna tanke, men vissa självrapporteringsstudier pekar på viss samstämmighet med uppfattningen (Noordsy m.fl. 1991 I: Meuser m.fl. 2001).

Supersensitivitetsmodellen

Supersensitivitetsmodellen bygger på tanken om psykobiologisk sårbarhet, där en kombination av genetisk sårbarhet/känslighet, psykosocialt instabil uppväxt och negativ påverkan av negativa omständigheter i vuxenlivet skapar psykisk sjukdom eller missbruk. Man talar om biologisk stresskänslighet/sårbarhet som kan förstärkas av både negativa omständigheter och missbruk. Sårbarheten kan göra psykiskt sjuka personer mer känsliga för droger och de negativa konsekvenser de medför. Det som framkommit i undersökningar visar att redan små mängder av droger troligen ger effekter så att sjukdomen förvärras och ökar sårbarheten hos personer med svår psykisk sjukdom. Man menar att schizofrenipatienter i

motsats till människor med personlighetsstörning ofta använder mindre mängder av droger, vilket inte lika ofta leder till fysiskt beroende hos denna grupp. Denna modell har sin motsvarighet inom primär alkoholism där den benämns typ I (Meuser m.fl. 2001). Typ I alkoholism, även kallad sporadisk eller miljöberoende alkoholism, är den dominerande gruppen bland alkoholmissbrukare. Man debuterar oftast i vuxen ålder och har sällan svåra sociala problem, men det psykosociala arvet tycks vara av stor vikt för hur missbruket utvecklas. Denna typ anses inte vara genetiskt betingad men påverkas negativt av påfrestande händelser i livet (Johansson & Wirbing 2001).

Ångest och depressioner

Inom forskning kring dubbeldiagnoser har flest studier gjorts kring schizofreni och manodepressiv sjukdom. Dessa sjukdomar förekommer dock hos minoriteten av missbrukare. Den största andelen missbrukare med dubbelsjuklighet lider av störningar med mindre allvarliga förlopp som personlighetsstörningar, ångest och depressioner. Ofta förknippas depressioner och ångest direkt med missbruket och anses minska efter en tids nykterhet. Meuser m.fl. (2001) menar att detta inte alltid är fallet utan att depressioner och ångest kan finnas oberoende av missbruket och att de båda inbördes tycks påverka varandra.

Enligt självrapporteringsstudier (Brown, Strout & Gannon-Rowley, 1998 I: Meuser m.fl. 2001) av dubbelsjuklighet med posttraumatiskt stressyndrom och drogmissbruk har man funnit att de båda symtomen påverkade varandra parallellt. Om det ena försämrades gjorde också det andra det. Studier har visat att KBT (kognitiv beteendeterapi) mot depressioner i kombination med beroendebehandling ökar effekten av behandling av båda sjukdomarna. Klienten får möjlighet att göra tankemässiga kopplingar emellan de båda tillstånden och blir mer kapabel att hantera symtomen och riskerar inte lika lätt att återfalla i den ena eller andra sjukdomen. Meuser m.fl. (2001) förespråkar, som vid behandling av svår psykisk sjukdom, även integrerad behandling vid ångest och depression.

Förekomst

För att återge lite siffror som berör förekomsten av personer med dubbel diagnostik hänvisar vi till en undersökning gjord i Stockholm av Romelsjö (2002 I: Palmstierna 2004). Av de 15500 patienterna som beroendeenheten var i kontakt med under 2001 visade det sig att ca 4500 personer eller 30 % även var inskrivna inom allmänpsykiatri. Utifrån den ökning man har sett från en studie gjord 1997 tror författaren att siffran kommer öka till 50 % inom en 5 års period. En annan undersökning visade att 50-60 % av de 1000 som intervjuats inom beroendevården hade någon gång de senaste 30 dagarna upplevt påtagliga psykiska problem. 40-70 % av dessa kände påtagligt eller stort behov av psykiatrisk hjälp (Romelsjö I: Palmstierna 2004).

Tidigare forskning visar att 65-85 % av alla narkotikamissbrukare lider av personlighetsstörning, tätt följt av depression och ångesttillstånd med 30-60 % och psykoser 10-15 % (Jansson & Fridell 2002). Gerdner och Sundin (1998) menar att begreppet dubbeldiagnos blivit ett modeord som inte speglar verkligheten. I många fall handlar det inte om dubbla diagnoser utan om flera. Som grund till detta påstående hänvisar de till en undersökning gjord på LVM-institutionen Runnagården där ett representativt urval av kvinnor genomgått psykiska intervjuer. Resultaten visar på att 53 % uppfyller kriterierna för minst en personlighetsstörning och 82 % uppfyller kriterierna för minst en psykisk sjukdom. Vidare är det också vanligt att dessa klienter uppvisar olika somatiska sjukdomar samt en allvarlig social problematik. Denna komplexa bild borde snarare betecknas som mångdubbelt trubbel (Gerdner & Sundin 1998).

Sammanfattning

De faktorer som enligt forskningen anses utgöra störst risk för dubbelsjukdom är antisocial personlighetsstörning och supersensitivitet/psykobiologisk sårbarhet menar Meuser m.fl. (2001). Dysforilindring och multipla riskfaktorer av social karaktär har också undersökts men bevisföringen för dessa teorier är tunn, även om det finns studier som tyder på viss relevans av uppfattningen. Ingen av modellerna är möjlig att påstå vara den enda rätta, men de ger gemensamt en något klarare bild av hur sambanden mellan vissa psykiska sjukdomar och missbruk ser ut. Någon generell orsaksförklaring är inte möjlig att göra även om man inom vetenskapen pekar på relevansen av vissa av dem. Den forskning vi i detta avsnitt har tittat på belyser främst svår psykisk sjukdom, dvs. schizofreni och till viss del manodepressiv sjukdom, som enligt forskningen löper störst risk att drabbas av samtidigt missbruk. Även antisocial personlighetsstörning, ångest och depression är mycket vanligt i samband med dubbelsjukdom med högst frekvens vid alkoholmissbruk. Oavsett förklaringsmodell till dubbelsjuklighet så visar sammanfattningsvis studier på att majoriteten av missbrukare även lider av någon sort psykisk ohälsa.

Behandling

I fokusrapporten "behandling av personer med komplexa vårdbehov pga. psykisk störning och missbruk" beskriver Palmstierna (2004) hur förekomsten och situationen för klienter med dubbeldiagnoser i Stockholm ser ut. Han redogör också för hur arbetet med dessa klienter teoretiskt och praktiskt bör bedrivas enligt Case Management och ACT (Assertive Community Treatment).

Case Management och Assertive Community Treatment (ACT)

Begreppet Case Management föddes i USA och har under åren fått olika betydelser. Grundidén handlar om att en manager tar ansvar och fokuserar på att vägleda och förmedla olika sorters vård till en enskild definierad klient med dubbeldiagnos. Denna grundidé kan liknas vid "mäklarmodellen" där mäklaren representerar klienten och ansvarar för samt ser till att klientens vardag struktureras. Senare modeller har inneburit att managern mer varit delaktig i behandlingen och jobbat i team tillsammans med bl.a. psykiatriker, sjuksköterskor och socialsekreterare (Lindström 2002 I; Palmstierna 2004).

ACT är en av de senare formerna av Case Management som dokumenterat har visat sig ge goda resultat i arbetet med klienter som lider av missbruk och psykisk störning. Här har case managern som uppgift att regelbundet träffa klienten och tillsammans planera behandlingen. Man arbetar uppsökande i klientens miljö, där man finns som stöd och till hjälp för att bl.a. se till att de basala behoven tillfredställs, t.ex. räkningar, mat, städning och hygien. Kontakten ska vara kontinuerlig och inte tidsbegränsad, vilket leder till förutsägbarhet och trygghet. En annan fördel med den uppsökande verksamheten är också att man vid eventuella återfall till missbruk eller till psykotiska tillstånd kan hämta klienten och köra honom till akutmottagning eller liknande. Arbetet ska ske i team där både beroendevård och psykiatrik finns representerade. I huvudsak är det teamet som tillhandahåller klientens vårdinsatser men vid behov av specialistvård samordnar case managern vården utanför teamet. Viktigt för klienterna är att de har möjlighet att kontakta teamet dygnet runt. Erfarenheter från ett projekt med psykiskt och socialt handikappade missbrukare visar att det dock sällan behövs akutåtgärder eller kontakt under natten, men vetskapen om att man dygnet runt kan få kontakt med personal skapar trygghet hos klienterna (Palmstierna 2004).

Integrerad behandling som ACT har enligt flera studier visat sig fungera bra på psykiskt störda missbrukare. De visar i jämförelse med traditionell behandling på bättre resultat vad gäller symtom, välbefinnande, hälsa och boende. Vidare visar resultaten på mindre antal slutenvårdsdygn, akutsjukvårdsinsatser och mer på öppenvårdsbehandling (Lehman m.fl. 1997 I: Palmstierna 2004).

Socialstyrelsens rapport ”Psykosociala effekter för personer med psykiska funktionshinder” redogör för olika faktorer som är centrala för case managerteam. De menar att verksamheten ska vara uppsökande och insatserna bör genomföras huvudsakligen i klienternas miljöer och inte på en mottagning. Vidare anser de att verksamheten ska ha hög intensitet och vara teambaserad med multidisciplinära kompetenser som psykiatriker och sjuksköterskor. Det är också viktigt att det är kontinuitet i personalgruppen samt att man har ett mindre antal patienter knutna till varje manager. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med klientens stödsystem t.ex. familj, hyresvärd, arbetsgivare, och andra vård- och stödinsatser. Case managerteamets specifika uppgifter är att ansvara dels för planering, beslut och uppföljning av insatser och de har även det samlade ansvaret för stödinsatser och att praktisk hjälp genomförs. Ytterligare uppgifter är att vara ombudsmän för klienten och bevaka dennes samhälliga rättigheter samt lokalisera och hålla kontakt med de sociala, medicinska och psykiatriska insatser som inte kan erbjudas inom teamet (Socialstyrelsen 2003, McHugo, 1999 I: Palmstierna 2004).

Helhet och Kontinuitet

Kontinuitet, socialt stöd och överbryggande mellan vårdinsatser har visat sig vara av stor betydelse för utfallet av missbruksvården, inte minst i samband med psykisk ohälsa. Socialt stöd både privat och professionellt har visat sig dämpa oro och ångest som annars är stora hinder för bl.a. behållandet av förändring.

Vid en av SiS (Statens institutionsstyrelse) LVM- (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) institutioner för kvinnor har man under en projektperiod arbetat med att efter avslutad LVM- vård på institutionen följa upp klienter under ett års tid. De grundtankar som projektet byggde på är hämtade från de principer för verksam behandling som NIDA (National Institute on Drug Abuse) har sammanställt. Några av grundprinciperna är att LVM- behandling bör pågå under en längre tidsperiod. Missbruksvård är en tidskrävande process där klienter ofta behöver återkomma på kortare och upprepade perioder av Sol- (socialtjänstlagen) placeringar. Genom att involvera behandlingsinstitutionen och finnas till hands efter avslutad LVM- placering i eftervårdsarbetet kan institutionen lättare avbryta och förhindra återfall i ett tidigt skede (Wärmegård 2005).

För att lämpliga behandlingsinsatser skall kunna sättas in är det nödvändigt för det professionella nätverket att ha kunskap om klientens hela sociala livsvärld. Detta tänkande skapar en helhet i behandling där insatser ses i en vårdkedja, där behandling och eftervård blir delar av ett långsiktigt förändringsarbete. Det sociala stödet utgör grunden i vårdkedjan och skapar kopplingar mellan de olika behandlingsinsatserna, såsom institutionsvård och eftervård (Wärmegård 2005).

Wärmegård visar i sin studie att arbetet med vårdkedjemodellen motverkar avbrott i förändringsprocessen. Genom att använda sig av vårdkedjemodellen och därmed se vården som en sammanlänkad kedja med stegvis överlämning och uppföljning har man nått goda resultat. Det långsiktiga arbetet med klienterna gör att de glapp som kan uppstå mellan LVM-

vården och den samordnande eftervården försvinner. Dessa glapp är ofta en bidragande orsak till att klienter tappar sin motivation och återfaller till den gamla destruktiva livsstilen (Wärmegård 2005).

År 2001 gjordes en undersökning på behandlingscentret Vibrant Futures i USA, där man bedrev ett treårigt drogbehandlingsprogram för ungdomar mellan 13-20 år (Duroy, Schmidt & Perry 2003). Programmet byggde på att man delade upp behandlingen i fyra steg som klienterna genomgick för att avslutningsvis komma ut i samhället som drogfria, engagerade och delaktiga medborgare. När de uppnått de uppsatta målen på ett steg gick de vidare till nästa. Undersökningen visar att övergången mellan dessa steg upplevdes som obehagliga och påfrestande för ungdomarna.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att man med kontinuitet i relationer och med en tydlig strategi under en längre tid har lyckats minska den oro, stress och rädsla det innebär för klienter att genomgå olika steg och övergångar i och mellan olika behandlingsprocesser. Oro, stress och rädsla är negativa faktorer som ofta leder till försämrad motivation och minskar fokus på de uppsatta förändringsmålen. Socialt stöd från familjen, behandlingspersonal och andra ungdomar har också varit betydelsefulla element i förändringsarbetet (Duroy, m.fl. 2003).

Socialt stöd

Enligt ytterligare en undersökning gjord i Kanada (Dobkin, Civita, Paraherakis & Gill, 2001) har det sociala stödet visat sig ha stor betydelse i fråga om oro, ångest och depression för klienten. Undersökningen visar att människor med starkt socialt stöd har mindre symtom av depression och oro än människor med svagt stöd, både under och efter missbruksbehandling. Även om behandlingen i sig är verkningsfull har depression och oro negativa effekter på bevarandet av behandlingsresultaten efter behandling samt hindrar klienten från att fokusera på sin uppgift och sina mål för nykterhet. Studien visar också att effekterna av socialt stöd är beroende av vem stödjaren är och hur stödet ges men också hur klienten mottar stödet. Här understryks vikten av uppriktiga, förtroendefulla och tillitsfulla relationer som förutsättningar för bra resultat.

Vidare menar författarna att socialt stöd för klienten kan finnas hos betydelsefulla medmänniskor, men har ingen positiv effekt om stödjaren delar klientens missbruk, beteenden och livsstil. Studien visar att socialt stöd har positiv betydelse för framgång i behandling men liten betydelse för det långsiktiga resultatet om det inte fortsätter efter avslutad behandling. Resultaten av studien belyser vikten av kartläggning och engagemang av socialt nätverk tidigt i behandling för att motverka ångest, depression och oro. Annars riskerar detta att äventyra klientens beslutsamhet och koncentration på förändring. Arbetet med klienters sociala nätverk medför att klienter kan ta till sig behandlingen men också bevara gjorda framsteg och fokusera på förändringsmål efter avslutad behandling (Dobkin, m.fl. 2001).

Effekter på behandlare och organisation

Tidigare studier visar att utsatta missbrukare med psykisk störning är vanligt förekommande framför allt bland dem som lider av personlighetsstörningar, men även bland dem som har psykosjukdomar. Ofta är dessa personer odiagnostiserade eftersom deras kontakter med vården sker oregelbundet och sporadiskt. Faran med att dessa personer inte blir diagnostiserade är att många behandlare och myndigheter ofta har inställningen att om diagnoser inte ställts, kan eller bör man inte behandla klienten/patienten. Anledningen till denna ibland omedvetna hållning hos professionella grundar sig i uppfattningen att de som

lider av dessa allvarliga psykiska störningar själva någon gång borde ha sökt vård för problemen och därigenom fått den diagnos som krävs. Förklaringen till att de inte gjort detta beror på det motstånd och den negativa laddning som finns kring begrepp som personlighetsstörning, borderlinestörning, psykopat osv. Detta leder alltså i många fall till underdiagnostisering och därmed utebliven psykiatrisk vård. Det som istället framträder blir då missbruket eller oförmågan att fungera i sociala sammanhang samt en aggressiv hållning till omvärlden (Palmstierna 2004).

De beteenden som dessa klienter uppvisar kan delvis förklaras i deras psykiska störning. Det kan handla om exempelvis problem med att upprätthålla relationer, stå ut med påfrestningar, använda lämpliga och normala känslöintryck, förstå andras känslor och önsningar osv. De människor som inom sjukvården, frivilligorganisationer, myndigheter eller liknande, möter dessa klienter påverkas ofta av klientens störningar utan att uppfatta vad som verkligen sker. De har svårt att kunna urskilja vad som är relevant och vad som är yttringar från störningen. Risken är stor att de i kontakten med klienter möter deras reaktioner inadekvat med s.k. motöverföringar, projektiva identifikationer och parallellprocesser (Palmstierna 2004).

När behandlare inom olika områden påverkas av klientens oförmåga att reflektera och handla situationsadekvat i vårdprocessen, är risken stor att det bli konflikter och motsättningar i samverkan mellan klientens olika vårdinstanser. Risken finns att klientens manipulativa beteende ses som rent bedrägeri och då stängs ute från verksamheten. Lösningen på dessa problem kan vara att man har en samverkan och en relation mellan de olika organisationerna innan klientkontakt blir aktuell. Vidare är grundläggande kunskap om hur man påverkas av psykiskt störda missbrukare nödvändig hos personal och arbetsledare. Det finns ett stort behov av utbildning inom psykiatri, socialtjänst och frivilligorganisationer samt gemensam patienthandledning över gränserna (Palmstierna 2004).

Klienter med svår psykisk problematik och missbruk har genom åren ofta utvecklat allvarliga komplexa problem. Oavsett metod och insats är det inte troligt att klienterna når full hälsa och social självständighet. Det är därför viktigt för behandlare och organisationer att räkna med långa vårdtider, annars är risken stor att både behandlare och patienter känner besvikelse över behandlingsresultaten (Palmstierna 2004).

Syfte och frågeställning

Syftet med vår studie är att få fördjupad kunskap och förståelse kring hur arbetet med missbrukare med psykisk ohälsa bedrivs av tre professionella aktörer, nämligen behandlingshem, psykiatri och socialtjänsten. Vi studerar även hur samverkan mellan aktörerna ser ut samt vilka faktorer som på olika sätt påverkar detta.

Frågeställningarna är:

- Hur ser arbetet ut kring klienter med psykisk ohälsa och missbruk hos behandlingshem, psykiatri och socialtjänst?
- Vilka roller har de olika aktörerna?
- Hur ser samverkan ut?

- Vilka faktorer påverkar samverkan?

Grundtanken i all forskning är att tillföra ny kunskap. Förhoppningen med vår studie är att hitta nya infallsvinklar i arbetet med missbrukare med psykisk ohälsa. Vi hoppas kunna väcka nya tankar och förståelse som kan komma till användning i förbättring och underlättande av vården av missbrukare i framtiden.

Teoretiska utgångspunkter

För att få en ökad förståelse för sambanden och samspelen i vården av missbrukare med psykisk ohälsa och på något sätt analysera studiens resultat, har vi valt att ta våra utgångspunkter från, Meads, Antonovskys och Habermas teoribildningar. Meads teorier använder vi för att belysa och förstå samspelen mellan människor och deras förståelse av varandra. Antonovskys teorier belyser vikten av att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet för människor i utsatta situationer. Vi har valt Habermas teorier för att förstå och belysa kommunikationen och samspelen mellan individ och samhälle/vårdorganisationer. Dessa teorier har under arbetets gång präglats och gett en djupare förståelse i ämnet. Vi ska därför redovisa teoriernas övergripande innehåll:

Meads teori om mänskliga samspel

Von Wright (2003) beskriver utifrån texter av Mead två olika synsätt på människans subjektivitet; det punktuella och det relationella perspektivet. Utifrån ett punktuellt perspektiv går endast beskriva vad en individ är, inte vem hon är. Med detta synsätt är varje människa ett fristående subjekt, skapad av sina omständigheter och sina medfödda egenskaper. Mänsklig kommunikation är ur detta perspektiv ett närmande mellan enskilda subjekt. Författaren vill genom presentation av olika synsätt, *förflytta uppmärksamheten från enskilda individers intellektuella förnuft, till känslomässigt förnuftiga handlande människor* (von Wright 2003 sid. 15).

Med hjälp av det relationella perspektivet flyttas fokus från enskilda kunskaper och egenskaper över till det gemensamma vilket är de sociala relationerna. I det relationella perspektivet ses individen i relation till och ständigt beroende av andra för att utvecklas. I detta samspel, intersubjektiviteten, som kan förstås som en kommunikativ process av meningsskapande, är människan i ständig förändring och utveckling. Att med bestämdhet säga vem någon är går inte eftersom vi ständigt i samspelet ömsesidigt påverkas och förändras av varandra. I handling mellan människor framträder det unika hos individen som ett vem. Man visar genom att tala och handla sitt själv, vilket ger en bild av vem man är (von Wright 2003).

Människan är social och behöver gemenskap och tillhörighet. Vi ingår i samspel med andra och grunden till detta är social omsorg, inte drifter eller instinkter. För att kunna ingå i samspel med andra behöver vi förstå och se mening i andras handlande samt i vårt eget. I meningsskapandet tar man någon annans perspektiv, där man sätter sig in i individens situation och reflekterar över dennes gester samt föregriper handlingar för att skapa en mening. Meningen blir då inte densamma för mig som för den andre eftersom det via mitt reflexiva tänkande blir en rekonstruktion av den andres handling och mening, inte ett direkt övertagande eller imitation. I denna process formas och omformas ständigt mitt själv.

Processen innehåller perspektivtagande där vi ser världen och oss själva ur någon annans perspektiv. Vi intar olika roller och attityder där vi genom denna ständiga process formar och omformar våra själv. Dessa perspektiv ger ett samlat resultat som författaren nämner som det generaliserande andra, med vilken vi har möjlighet att i självet föra dialog, tänka och reflektera, utifrån andras perspektiv (von Wright 2003).

Antonovskys salutogena modell

År 1970 genomförde Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, en undersökning bland kvinnor födda mellan 1914-1923 i Centraleuropa. Det han undersökte var deras psykiska hälsa. Hans forskning gick ut på att jämföra kvinnor som överlevt 2:a världskrigets koncentrationsläger med en kontrollgrupp kvinnor som inte varit utsatta för detta trauma. När han sammanställde resultaten visade siffrorna att 51 % av kvinnorna i kontrollgruppen och 29 % av dem som överlevt koncentrationslägren hade god psykisk hälsa. Det faktum att den psykiska hälsan hos dem som genomlidit koncentrationslägren var lägre än kontrollgruppen är logiskt, med tanke på att de genomgått en grym tid i lägren samt flera år som flyktingar.

Antonovsky (1991) vänder på tanken och det klassiska resonemanget och konstaterar att det nästan är en tredjedel som mår psykiskt väl trots allt (resultaten visade också på fysiskt välmående). Efter denna slutsats undrade Antonovsky vilka faktorer som spelat in i kvinnornas liv och i så fall vad det var för specifikt som skiljde dem från de andra 71 % som led av ohälsa. Denna vändning, att leta efter det friska istället för det sjuka, kallar han den salutogena modellen, vilken senare låg till grund när Antonovsky undersökte de gemensamma nämnare som återfanns hos dessa kvinnor. Det som förenade de undersökta var det som sammanfattades till KASAM (känsla av sammanhang). KASAM delar han in i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

- **Begriplighet** syftar till hur man uppfattar yttre påverkan (stimuli). En situation kan uppfattas på flera olika sätt t.ex. ordnad, strukturerad, kaotiskt, oförklarlig och oväntad. En person med hög grad av begriplighet förväntar sig att saker och ting kommer att hända. Uppstår oförutsedda stimuli klarar en sådan person av att ordna och förklara dessa händelser, man har en förmåga att bedöma verkligheten. I undersökningen uttryckte dessa personer ofta att saker och ting kommer att lösa sig.
- **Hanterbarhet** är KASAM:s andra komponent. Den beskriver personers förmåga att hantera yttre stimuli, t.ex. att kunna se vilka resurser man har till förfogande för att bemöta ett problem. Sådana resurser kan vara en kollega, livspartner, Gud, historien, läkare eller sammanfattningsvis någon man kan räkna med. Har man hög känsla av hanterbarhet ser man sig inte som ett offer utan accepterar att olyckliga och hemska saker trots allt händer och att tiden/perioden av sorg delvis kan avgränsas.
- **Meningsfullhet** är den sista delen som också beskrivs som en motivationskomponent i begreppet KASAM. Den handlar om graden av delaktighet i de sammanhang som påverkar ens vardag och öde. De människor som känner en hög grad av meningsfullhet beskriver i undersökningen ofta områden i livet som varit viktiga för dem och engagerat dem både känslomässigt och kognitivt. Formellt syftar komponenten till att man känner att livet har en känslomässig innebörd och att problem man ställs inför är värda att investera energi i (Antonovsky, 1991).

Upplevelse av mening och sammanhang är nödvändigt för vår fysiska och psykiska hälsa vilket skapas genom upplevelsen av samtidig frihet och gemenskap. Känsla av sammanhang

är intimt sammankopplad med hur man utvecklar en bemästringsförmåga, en förmåga att hantera svåra situationer konstruktivt, utan att förneka eller förtränga de negativa känslor dessa medför. För att känsla av sammanhang ska uppstå måste vi begripa vad situationen vi är i innebär, men också ha möjlighet att mobilisera resurser hos oss och från andra i vår närhet. Det är även betydelsefullt att se problemet i ett meningsfullt livssammanhang, men också ha en känsla av att tillhöra en större helhet. Känslan av att själv styra sitt liv är av stor vikt.

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991 sid. 41).

Habermas kommunikationsteori

Grunden till Habermas kommunikationsteori föddes ur den tyske filosofen Hegels teori (upplysningens dialektik) om att individuell framgång och effektivisering leder till främlingskap och objektivisering, där medmänniskor ses som ting (Fritzen 1998). Vidare ur detta resonemang föddes i tyskland en tradition (The German line) där socialfilosofer som Marx, Weber m.fl ingick. Det som förenade dessa filosofer, som på andra områden var ganska olika, var påståendet om att det existerar motsättningar mellan individen och det moderna samhället.

Samhället, d.v.s. det "moderna" industrialiserade, västerländska samhället, anses befinna sig i en historisk utvecklingsprocess i vilken individens frihet och självständighet i en eller annan mening är hotad eller undergrävd, och i vilken personlighetsmässig utveckling egentligen bara kan ses genom att samhällets inneboende dynamik på ett eller annat sätt förnekas eller trotsat (Fritzell, 1989 s.7-8 i Fritzen 1998).

Habermas delar denna uppfattning men tar resonemanget ett steg längre, till skillnad från de i detta fall pessimistiska klassiska filosoferna som fokuserar på det enskilda subjektet och dess handlande. Han menar att intersubjektiviteten, alltså kommunikationen mellan subjekt – subjekt är en möjlighet och ger nya funktioner som de klassiska filosoferna inte på samma sätt berör. Habermas delar in sin teori i två delar, han talar om livsvärld och system (Fritzen 1998).

Kommunikativt handlande eller interaktion med avsikt att uppnå gemensam förståelse är en förutsättning för att vi ska kunna bevara våra sociala sammanhang och normer. Livsvärlden är det sammanhang/värld/område där denna interaktion ges utrymme. Det är i livsvärlden vi genom vårt språk samtalar, kommer överens och klargör våra åsikter som ligger till grund för vårt handlande.

Termen system, som inom biologin och ekonomin beskriver ett sammanhang som är ordnat och strukturerat, vill Habermas använda inom samhällsfilosofin. Han menar att det moderna samhället har flyttat ekonomi och statsapparaten från livsvärldens kommunikativa tänkande mot systemets logik. Denna logik handlar framför allt om effektivisering, pengar och makt.

Han menar att den grundläggande roll som språket har i livsvärlden, har dessa komponenter i systemet. Problemet som oroar Habermas är att systemet mer och mer koloniserar livsvärlden och tar över områden där livsvärldens logik bör styra. Risken är stor om detta fortgår att människor mer och mer förlorar sin frihet och självständighet som kunskapande och fritt handlande individer. Habermas ser dock inte systemet som oberoende av livsvärlden utan menar att de påverkar varandra. Författaren drar en parallell till skolan där statens myndigheter måste ta hänsyn till föräldrars och medborgarnas uppfattning om vad skolan ska innehålla samtidigt som föräldrarna är beroende av att staten organiserar skolans struktur (Fritzen 1998).

Croona (2003) skriver att i en hierarkisk organisation är makten uppdelad till vissa människor vilket ger dessa tolkningsföreträderna, vilket i sig kan medföra att den kommunikativa förståelsen förs åt sidan. Detta effektiva system som vi i samhället efterfrågar behöver dock inte automatiskt innebära något negativt. Om livsvärldens logik får verka i systemets delar kan kombinationen fungera på ett tillfredställande sätt. Problemet är att systemet inte ställer krav på annat än effektivitet. Detta innebär att det kommunikativa förhållningssättet, alltså livsvärlden, är hotad vilket leder till negativa effekter för människor, särskilt inom människovårdande områden (Croona 2003).

Metodologiska utgångspunkter

Olika forskningstraditioner

För att man inom forskning ska kunna uppnå vetenskaplig kunskap krävs vetenskapsteorier menar Hartman (2004). Det förekommer två grundläggande vetenskapliga traditioner, den positivistiska och den hermeneutiska. Positivismen kommer ur naturvetenskapen och syftar till att observera och objektivt beskriva verkligheten som den är. Här finns inte utrymme för tolkningar utan positivismen syftar snarare till att ge sanningar om hur världen ytterst är beskaffad.

Hermeneutiken är teorin om hur vi förstår andra människors upplevelser av världen och skapande av mening för det som händer i den. Hermeneutiken formar allmänna regler för tolkandet av människors meningsskapande. Avsikten är att skapa godtagbar förståelse för människors uppfattning av tillvaron. Här talas inte som i positivismen om mätbart exakt/absolut sanning utan snarare om giltig mening, tolkning och förståelse av tillvaron. Eftersom alla människor är unika i sin förståelse av tillvaron är det inte heller möjligt att finna en exakt förklaring eller sanning i hur samspel mellan människor i samhället fungerar (Hartman 2004).

Kvalitativ metod

Kvalitativ forskning är inte lätt att definiera pga. att det bland annat finns olika traditioner och att kvalitativa forskare ser begreppet på olika sätt. Bryman (2004) menar dock att den kvalitativa undersökningsmetodens syfte är att undersöka hur människor upplever världen. Genom bl.a. intervjuer och observationer bildar man sig uppfattningar och tolkar människors upplevelser av sociala strukturer och händelser etc. i personens livsvärld. Det som också kännetecknar kvalitativ forskning är den induktiva processen som innebär att nya teorier kommer ur de resultat undersökningar genererar. Man utgår alltså inte deduktivt från tidigare undersökningar och teorier (Bryman 2004).

Val av metod

Vi har valt att genomföra vår uppsats utifrån hermeneutiska vetenskapstradition och kvalitativt undersöka samhälleliga funktioner. Anledningen till detta beror på att vi är intresserade av att få ökad kunskap och förståelse för hur de tre olika aktörerna ser på behandlingen av klienter med psykisk ohälsa och missbruk. Det väsentliga är inte att hitta sanningar utan möjligtvis olika likaväl som gemensamma utgångspunkter och förståelsemodeller som belyser verkligheten och de olika aktörernas roller inom området.

Vi har också använt oss av positivistisk forskning i vår bakgrund som kvantitativt visar på antalet missbrukare med psykisk ohälsa. För att öka vår studies relevans blir siffrorna som belyser förekomsten av psykisk ohälsa hos missbrukare en tillgång. Vi menar att relationen mellan samhällsvetenskapen och den hermeneutiska vetenskapstraditionen är tydlig, men samtidigt också att den positivistiska traditionen kan spela en betydande roll i samhällsvetenskapliga forskningssammanhang.

Intervju som datainsamlingsmetod

När det gäller datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av intervjuer. Detta främst för att intersubjektivt tillsammans med de intervjuade skapa mening kring deras föreställningar av det aktuella ämnet. Denna metod innebär att vi tillsammans skapar en tillitsfull relation där informanterna har möjlighet att ge sin bild av det vi undersöker. Om vi istället använt oss av observationer hade våra egna föreställningar till större del legat till grund för resultatet av studien. Nackdelen med detta hade i vårt fall blivit en mer ensidig syn på det undersökta. Ett tredje alternativ hade varit deltagande observation som kan ses som en blandning mellan intervju och observation. Fördelen med denna datainsamlingsmetod hade i vårt fall varit en blandning av de undersökta föreställningar med våra egna uppfattningar av det observerade.

Denna metod hade förmodligen gett mer och djupare information men är mer tidskrävande, vilket inte passar in i vår tidsbegränsade studie. Likaså finns det etiska hinder som vi redogör för under rubriken forskningsetiska överväganden. När det gäller människosyn kan observation och deltagande observation uppfattas som mindre tillitsfulla. Detta eftersom större delar av kontroll, via forskarens närvaro i varierande grad, ingår i dessa två metoder. Förhållandet mellan forskare och de intervjuade blir lätt ojämlikt, vilket kan uppfattas som om undersökaren genom det observerade har tolkningsföreträde till de undersökta livsvärld.

Analys och tolkning

Med utgångspunkt i en hermeneutisk ansats via intervjuer och dialog med informanter skapas ett textmaterial, som senare kan bearbetas genom den hermeneutiska spiralen. Kvale (1997) menar att detta innebär en ständig pendling mellan olika delar i tolkningsprocessen där helhet såväl som enskilda delar och teman växelvis bearbetas och skapar fördjupad förståelse genom varandra. Syftet är att så småningom bringa fördjupad förståelse för informanternas upplevelse av sin livsvärld och fenomenen i denna. För att skapa mening i det som sagts i intervjuerna krävs en analys. Avsikten med att analysera är att ur intervjuerna samla ihop och strukturera svaren till relevant information utifrån studiens syfte och frågeställning.

Utan en analys blir materialet obearbetat och svåråtkomligt och utan någon större relevans för undersökningen. När materialet är analyserat måste det tolkas för att göra det allmänt begripligt. Genom tolkningen redogörs och förtydligas teman som uppkommit under intervjun. Texterna får inte liv förrän de tolkas eftersom interaktionen mellan de intervjuade och intervjuaren inte är synliggjorda i intervjutexten. Genom att tolka in gester och underförstådd information ur det mellanmänniska samspelet i intervjusituationen, lyfter man

innehållet till en högre nivå och ger därmed innehållet större rikedom på mening (Kvale 1997).

Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet

Historiskt sett var den positivistiska forskningstraditionen det första och enda sättet att bedriva forskning på. Viktiga delar inom traditionen handlade och handlar fortfarande om begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Med validitet menas att en undersökning verkligen undersöker det som är avsett utifrån frågeställningar och syfte. Med begreppet reliabilitet menas att man använt sig av korrekta undersökningsinstrument i sin forskning och att man exempelvis inte använder sig av måttstock när man undersöker föremåls vikt. Om man har låg reliabilitet, alltså inte använt sig av relevanta instrument i en undersökning, blir validiteten automatiskt också låg och undersökningen tappar sitt värde. Då kan man inte heller generalisera resultatet, alltså inte tillämpa och överföra det till andra sammanhang (Bryman 2002).

När den hermeneutiska traditionen växte fram uppstod frågan om man ska, eller överhuvudtaget kan överföra begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Här delar sig de hermeneutiska forskarnas mening. Anledningen till detta beror, enligt Bryman (2002), på att det inte går att hitta en enda sann bild av den sociala verkligheten som begreppen kräver utan att det finns flera bilder. Det går inte att direkt generalisera resultatet eftersom det ofta är ett för litet antal undersökningsspersoner i urvalet i en kvalitativ studie. Man kan inte heller frysa sociala sammanhang eftersom de hela tiden är under förändring. Detta innebär att andra personer i efterhand inte kan gå in och mäta reliabiliteten genom att göra en likadan undersökning (Bryman 2002).

Lincoln och Guba (I: Bryman 2002) föreslår att man bortser från begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och istället använder sig av alternativ som handlar om tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. Vi ska utifrån Bryman utveckla vad Lincoln och Guba menar med dessa begrepp. Tillförlitlighet handlar om att följa de regler som finns uppsatta kring den forskning man utför samt att man ger en rapportering av materialet till de intervjuade s.k. respondentvalidering. De får då möjlighet att bekräfta att verkligheten som beskrivs överensstämmer med deras uppfattning eller om beskrivningen ska omformuleras.

Motsvarigheten till den positivistiska reliabiliteten är pålitlighet, som handlar om att klart visa hur man gått tillväga. Man visar tydligt och lättåtkomligt val av undersökningsspersoner, hur forskningsprocessen gått till, problemformulering och sina datamaterial. Detta material kan man sedan låta någon kunnig inom området gå igenom, granska och bedöma kvaliteten på, vilket ökar och till viss del säkrar pålitligheten. En svårighet med detta arbete är att kvalitativa undersökningar ofta medför en stor mängd data, vilket resulterar i ett krävande arbete för den utomstående som ska granska studien (Bryman 2002). I vårt fall har en handledare granskat vårt tillvägagångssätt och material under processen för att säkra vår studies pålitlighet.

Överförbarhet handlar inte om att kunna generalisera sin studie som är ett av den positivistiska traditionens mål. Lincoln och Guba (I: Bryman 2002) menar istället att överförbarhet sammanfattar det unika i sammanhanget av den sociala verklighet som undersöks. Det handlar om att gå på djupet och göra en tät beskrivning. Resultatet framförs sedan till andra människor som själva får bedöma och ta ställning till hur överförbar/användbar studien är i deras miljö och sammanhang (Bryman 2002).

Vår förförståelse

Efter två och ett halvt års studier i pedagogik med inriktning mot ungdoms och missbruksvård och genom praktik och yrkeserfarenhet i området har vår förståelse och kunskap i ämnet formats. Ett helhetsperspektiv är avgörande i människors förändringsarbete. Med helhetsperspektiv menar vi att alla problemområden i människors liv måste finnas med för en hållbar förändring. Vi menar också att enkla förklaringar, orsaker eller lösningar på problem inte existerar. I arbete med människor krävs långsiktighet, flexibilitet, empati, bred förståelse och framför allt ett relationellt tänkande där kommunikation är bärande. Experttänkande och färdiga svar och lösningar för människors livssituation tror vi inte är en framkomlig väg i hållbar förändring.

Upplägg

Förberedelser

De förberedelser vi gjorde inför studien var att orientera oss i de olika organisationernas struktur för att finna lämpliga informanter som arbetar med personer som lider av missbruk och psykisk ohälsa. Med hjälp av handledare och andra kunniga inom området fick vi tips och råd om tillvägagångssätt och om litteratur. Genom uppförandet av en projektplan och genom litteraturen har vi tillgodosett de grundläggande kunskaperna som kvävs för att genomföra studien.

Urval

Vi har valt att strategiskt göra vårt urval av undersökningspersoner. Intervjupersonerna kommer från socialtjänsten, behandlingshem och psykiatri, vilka är de tre huvudaktörerna inom området. Valet att intervjua personal från socialtjänsten beror på att de i de flesta fall står som uppdragsgivare gentemot behandlingshem inom missbruksvården. Personerna inom socialtjänsten som handlägger dessa ärenden har kunskap om planering och samverkan kring klienterna. När det gäller psykiatri har vi intervjuat personal som arbetar med patienter med missbruksproblem. Dessa intervjupersoner är intressanta eftersom de i huvudsak innehar kunskap kring psykisk ohälsa. Behandlingspersonal på behandlingshem som aktivt arbetar med vuxna missbrukare är intressanta i undersökningen, eftersom de ofta har nära relationer med klienterna samt åsikter om hur samverkan kring klienterna fungerar. Vi tror att de kan ge en kompletterande bild till de två övriga grupperna.

Vår analys och tolkning

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar ordnade vi teman och underliggande frågor som vi utgick ifrån och använde som röd tråd att följa genom intervjun. När detta arbete var klart genomförde vi en pilotintervju, för att få svar på och hitta brister i de teman och frågeställningarna som gjorts. När vi genomförde intervjuerna ställde vi inte strukturerade frågor utan samtalade snarare fritt utifrån våra teman. Under intervjusamtalen försökte vi spegla och återföra till informanterna det som sagts, för att få bekräftelse på att vi tolkat informationen på ett tillförlitligt sätt. Vi använde oss av inspelningsutrustning för att sedan ha möjlighet att transkribera, för att i skrift få relevant information och kunna sälla bort oväsentligheter.

När materialet var transkriberat till text sorterade vi in relevanta delar av intervjuerna under våra temarubriker från intervjuguiden. Vi analyserade resultatet för att hitta gemensamma samt skilda upplevelser och åsikter mellan de olika informanterna. Utifrån detta skapade vi

nya teman för att om möjligt sortera och koncentrera materialet. I detta skede var det möjligt att se och tolka innebörden, underliggande meningar och strukturer som inte enbart framgick ur de enskilda textmaterialen utan som också framkom i den interaktion som uppstod mellan intervjuperson och oss som intervjuare. Vår tolkning skrevs ner och blandades med citat under kategorier i vår resultatdel. Genom växelvis analys av arbetets enskilda delar och helhet har vi gett materialet mening och gjort det allmänt begripligt. Det är detta Kvale (1997) kallar den hermeneutiska spiralen.

Vårt syfte och våra frågeställningar tillsammans med resultatdelen samt de olika teorier som vi fördjupat oss i med hjälp av litteraturen har gett oss möjlighet att tolka och problematisera kontentan av det som framkommit under intervjuerna. Detta har gett oss möjlighet att skapa ytterligare mening och förhoppningsvis även dra idéskapande slutsatser av arbetet. Tanken med vår studie är och bör vara ämnad att väcka tankar som kan bidra till förbättringar inom området.

Forskningsetiska överväganden

När det gäller forskningsetik i samhällsvetenskapliga studier finns det vissa grundläggande etiska och moraliska aspekter som måste uppmärksammas. Det handlar ibland om svåra gränsdragningar och ställningstaganden som forskaren har att ta ställning till. Ytterst står denne ansvarig för att forskningen bedrivs på ett moraliskt riktigt sätt, utan att vare sig skada eller kränka människor. Även kravet på kvalitén i forskningen är av stor betydelse, eftersom syftet är att tillföra samhället ny och djupare kunskap. Några frågor man i dessa sammanhang skall ställa sig är, gör undersökningen mer nytta än skada, riskerar jag genom undersökningen att kränka någons integritet eller privatliv, kan intervjupersonernas identitet skyddas osv. Bryman (2002) tar upp fyra grundläggande principer vad gäller individskydd och forskningsetiska överväganden inom svensk forskning:

- **Informationskravet** innebär att undersökaren beskriver för de berörda vad som är studiens syfte samt ger information om studiens tillvägagångssätt. Det ska också förekomma information om att deltagandet är frivilligt och att man får avbryta deltagandet under tiden om så önskas.
- **Samtyckeskravet** betyder att deltagarna själva ska få bestämma över sin medverkan. Det är med andra ord inte korrekt att ställa frågor som används i forskningen utan att ett samtycke till intervjun finns dokumenterat. Om undersökningspersonerna är barn kan vårdnadshavarens underskrift för godkännande vara nödvändig.
- **Nyttjandekravet** innebär att materialet som samlats in enbart får användas till forskningsändamålet.
- **Konfidentialitetskravet** innebär att deltagarnas personuppgifter ska hållas konfidentiella och bevaras så utomstående inte kan ta del av uppgifterna (Bryman 2002).

En konfidentiell undersökning är dock inte samma sak som en anonym. Skillnaden är att i en anonym undersökning kan inte ens forskarna koppla informationen till respondenterna. Enligt våra bedömningar och överväganden är inte vår undersökning möjlig att genomföra om intervjupersonernas identitet skall vara anonym, eftersom ett möte mellan respondent och

undersökare i de flesta fall förekommer vid intervjuer. Dessutom är vår undersökning inte av så känslig karaktär att anonymitet är befogat. Våra frågeställningar är inte av privat eller intim karaktär och ämnet rör snarare professionella frågor än personliga.

Vi har valt att intervjua tre olika kategorier av arbetsplatser med två intervjupersoner från varje. Vi anser dock att det finns en risk med att intervjua personer från samma enhet. Risken är att negativ information, om sådan finns, uteblir om den intervjuade vet att den andra respondenten från samma enhet kommer att ta del av slutmaterialet. Vi har därför valt sex oberoende enheter för att säkra att individens identitet inte röjs samt för att möjligen få en mer utförlig beskrivning. I början av vår undersökning tog vi via telefon kontakt med respektive intervjuperson för att se om intresse för deltagande har fanns. Vi har även vid detta tillfälle informerat om studiens intresseområde och syfte. Efter telefonkontakt har förfrågan om deltagande via brev skickats till intervjupersonerna där mer ingående information om vår studie har bifogats. Varje intervju har börjats med en muntlig genomgång av de fyra grundläggande etiska riktlinjerna, där vi förvissat oss om att intervjupersonerna varit införstådda med dess innehåll.

Tidigare i texten tog vi upp att deltagande observation skulle ha varit en lämpligare undersökningsmetod för kunskapsinhämtandet än intervju, men att det pga. tidsbrist och etiska hinder inte gick att genomföra. Om vi skulle ha gjort deltagande observationer hade det lämpligast gjorts på olika behandlingshem, socialkontor och psykiatriavdelningar. Vi hade då själva deltagit och ställt frågor till klienter och personal om deras uppfattning av tillvaron. Med tanke på att vi gör vår första undersökning samt att den rör känsliga ämnen som missbruk och psykisk ohälsa anser vi det därför oetiskt att använda oss av deltagande observationer. Risken finns att vi utifrån vår kompetens inom området inte hade kunnat hantera de tankar och känslouttryck vi möjligen väckt.

Resultat

Inledning

I vårt resultat har vi sett och urskiljt likheter såväl som olikheter på synsätt i frågor som rör vården av missbrukare med psykisk ohälsa. Vi kommer att redovisa intervjuresultatet under rubrikerna nedan. Under rubriken "Presentation av intervjupersonerna" kommer vi att beskriva de sex intervjupersonernas arbetsplatser, befattningar och erfarenheter. Under rubriken "Gemensam uppfattning" ges en beskrivning av områden och uppfattningar som intervjupersonerna är överens om. Vidare redovisas olika synsätt på målsättningar och diagnoser under rubriken "Olika traditioner". Det finns idag till viss del ett fungerande samverkan mellan aktörerna och detta belyser vi närmare under "Samverkan". De svårigheter och problem som finns i samverkan mellan de tre olika aktörerna beskrivs under "Vad hindrar samverkan?"

Presentation av intervjupersoner

Intervjuperson 1 är behandlingschef på ett medelstort behandlingshem. Arbetsuppgifterna är bland annat att handleda och utbilda personal samt praktiskt hjälpa till i behandlingsarbetet. Behandlingshemmet vill se sig som ett komplement till psykiatri och tar främst emot klienter, både män och kvinnor, med tablett och blandmissbruk. Intervjuperson 2 är behandlingschef på ett stort privatägt behandlingshem, vari intervjupersonen är delägare. Den intervjuade har ca 15 års arbetslivserfarenhet inom missbruksvården.

Den 3:e intervjupersonen är processansvarig inom psykiatrins beroendeenhet, där huvuduppgiften är att anpassa och tydliggöra brister samt hålla rätt nivå på vården. Processansvaret sträcker sig även till andra delar i psykiatrin för att patienter inom andra områden också ska få del av beroendeenhetens vård om behovet finns. Intervjuperson 4 jobbar som socialsekreterare på en socialbyrå i en mindre stad. Den intervjuade arbetar i missbruksgruppen där man handlägger ärenden som rör vuxna missbrukande män och kvinnor från 20 års ålder. Tidigare arbetade intervjupersonen med frivillig öppenverksamhet för missbrukare. Sammanlagt har den intervjuade mer än 20 års erfarenhet inom missbruksvården.

Vår femte intervjuperson jobbar på en psykiatriavdelning som sjuksköterska. Avdelningen innehåller akut psykiatrisk sjukvård, avgiftning och slutna beroendevård. Den intervjuade har många års erfarenhet inom psykiatrin. Intervjuperson 6 arbetar som socialsekreterare inom socialtjänsten i en större stad. Klienterna är män och kvinnor över 30 år. Intervjupersonen har erfarenhet som enhetschef på ett litet socialkontor men återvände till handläggararbetet eftersom saknaden av klientkontakten blev för stor.

Vidare i resultatet kommer vi att skilja på de olika professionerna, genom att benämna intervjupersonerna från behandlingshemmen som B, socialtjänsten som S och psykiatrin som P. Vi vill förtydliga att åsikterna i citaten i vissa fall skiljer sig åt oberoende vilken profession intervjupersonerna tillhör.

Gemensam uppfattning

De likheter som främst framkommer genom intervjuerna är inte grundade i ideologier eller syn på missbruksvården utan snarare ett uttryck för intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. Vi börjar med att beskriva gemensamma uppfattningar om förekomst av samtidigt missbruk och psykisk ohälsa samt orsaker till detta och val av droger under rubrikerna, "Förekomst", "Vad är orsaken" och "Drogval kopplat till speciell problematik".

Förekomst

Intervjupersonerna är överens om att de flesta missbrukare de är i kontakt med också lider av psykisk ohälsa. Uppfattningar om begreppet dubbeldiagnos är entydigt. Andra begrepp som samsjuklighet och multipla diagnoser är mer rättvisande eftersom problembilden oftast är mer komplex än endast två diagnoser. Majoriteten av missbrukare lider av psykisk ohälsa i någon form oavsett om de är diagnostiserade eller inte.

B: *Ca 85 % hos oss har en diagnos. Resten har väl inte hamnat inom psykiatrin så man har inte hunnit få sin diagnos, vilket de skulle ha fått.*

S: *Min känsla av det jag har sett, så tror jag att 60 % har någon form av psykisk störning. När jag säger 60 % då menar jag alla som har symtom.*

P: *Jag tycker det är så svårt med det begreppet. Vi väljer ju att inte säga dubbeldiagnoser för de flesta har ju fler än två.*

Orsak

På frågan om vad som föder vad, om det är missbruket som ger psykisk ohälsa eller tvärtom, har vi fått entydiga svar. Här anses att en enkel allmän förklaring på detta inte går att ge. Men

de flesta missbrukare med psykisk ohälsa man möter i verksamheterna har en historia som innefattar traumatiska upplevelser under uppväxttiden. I längden förstärks också den psykiska av missbruket.

S: *Det som är mest vanligt förekommande är att det har funnits missbruk i familjen. Och då finns det ju också brister i omsorgen och i relationen mellan föräldrar och barn i de miljöerna.*

P: *I regel har det funnits en problematik innan och så missbrukar man på det, det är klart att man blir ju inte friskare då va. Alla deras störningar förstärks ju sedan i missbruket.*

Drogval kopplat till speciell problematik

Intervjupersoner menar att alkoholmissbruket i allmänhet har ökat, men den vanligaste typen är blandmissbruk. När det gäller kopplingar mellan drogval och psykisk problematik går det inte att se några generella kopplingar. Någon tycker sig dock ha sett att svårt psykiskt sjuka som exempelvis personer med schizofreni eller annan psykotisk problematik inte accepteras i narkotikakretsar. Detta innebär en mindre förekomst av narkotikamissbruk bland dessa, men däremot en större alkoholkonsumtion eftersom tillgängligheten på alkohol är större. Eftersom man inte generellt kan se några kopplingar mellan drogval och psykiska symptom avfärdar man självmedicineringsbegreppet. Däremot används droger generellt för att underlätta de ofta traumatiska upplevelser man bär med sig.

B: *Finns det en riktig psykisk sjukdom med psykoser där du inte kan hålla ihop dig själv är du inte accepterad i knarkvärlden, för där ska man vara kriminell, du måste ändå sköta dig i en viss bemärkelse. Om polisen kommer kan du inte sitta och gola ner alla dina kompisar. Så dom är inte välkomna i knarkvärlden. Vad har dom kvar då, när man har stängt ner mycket av psykiatin? Mycket psykiskt sjuka och ensamma människor har ju lättare att få tag på alkohol än knark. Här kan man se en koppling mellan riktiga psykiska sjukdomar och alkohol.*

S: *Man kan spekulera i mycket hur man sköter sin självmedicinering, vilken medicin inom citationstecken som är bäst för vilket symtom och det har man väl inte riktigt kunnat se några tydliga samband när det gäller det. För många stoppar ju i sig allting. Så jag tror inte det finns någon så där medveten tanke att det är någon speciellt drog man ska ha för att bota sina symtom.*

Olika traditioner

I följande delar av vårt resultat har vi urskiljt skillnader mellan intervjupersonerna av mer ideologiskt traditionellt bunden natur. De synsätt som främst framträder är ett psykosocialt synsätt och ett medicinskt/biologiskt synsätt. Med ett psykosocialt synsätt, som blir tydligast hos behandlingshem och socialtjänst, flyttas fokus bortom medicinska diagnoser till bl.a. bakomvarande orsaker till problem och till sociala faktorer i klientens livssituation. Med detta synsätt blir relationer av stor vikt för att möta och hjälpa klienten, vilket beskrivs under rubriken "Helhet som mål". Det medicinska/biologiska synsättet som främst syns inom psykiatin är mer benäget att se lösningar på dubbelsjuklighet genom diagnoser och medicinering. Detta synsätt beskrivs under rubriken "Delar av helheten som mål".

S: Det är väl mycket gamla traditioner som man brottas med, att det ska vara rationellt och om möjligt välorganiserat, för det är ju så inom sjukvården, med tider och så. Inom socialtjänsten har vi en tradition att vi möter klienterna mer, vi går ut på fältet, vi gör hembesök och är vi oroliga för någon så ringer vi upp, vi byter några ord. Men det gör ju, skulle jag vilja påstå, aldrig sjukvården utan du får komma till mig på mina villkor, på mina tider och äta mina mediciner och så. Vi har olika förhållningssätt socialtjänst och sjukvården.

Helheten som mål

Målsättningen för behandlingshemmen och socialtjänsten är att tillsammans med klienten i en relation skapa en förståelse för dennes situation och utifrån den hitta målsättningar för framtiden. En grundläggande del för klientens förändringsarbete är att målsättningen med vården stämmer överens med inblandade parter målsättningar. En samsyn kring klientens problematik är nödvändig för att få till stånd en långsiktig förändring. Man bör arbeta med kartläggning och förtydligande av klientens situation för att göra den mer begriplig och därmed öka klientens motivation till förändring.

B: Om de här parterna inte är överens. Om klienten säger en sak till oss och vi inte är överens med uppdragsgivaren, socialtjänsten eller... det blir aldrig bra. Därför är det ett av de viktigaste arbetena att prata så att vi är överens.

S: Det är ju att kunna tillgodose våra klienters behov så mycket som möjligt. Och vår målsättning blir ju deras målsättning på något sätt, att vi försöker tillgodose det.

En uppfattning om detta klientcentrerade arbete är att man måste beröra alla områden i klientens värld för att kunna hjälpa klienten med att få en heltäckande förändring.

B: Vi vill jobba med hela människan, alla bitar. Vi ser det som att man inte kan jobba med missbruk på våra patienter om man inte jobbar med hela människan för annars kommer de aldrig att kunna bibehålla sin drogfrihet på längre sikt. Att få dem att vilja se hur det är i nuet och vad är målsättningen i ditt liv, stämmer det överens med hur du lever idag? Vad kan du och vi tillsammans göra för att nå din målsättning?

En annan uppfattning som vi sett hos både behandlingshem och socialtjänst är att diagnostisering kan sätta hinder i förändringsprocessen. Diagnoser ger en smal och förenklad förklaring till dessa människors komplexa problematik. Det kan leda till att klienter och behandlingspersonal låser fast sig vid diagnoser och därmed inte kan se möjligheter till förändring. Samtidigt menar man att en satt diagnos trots allt kan ge större möjligheter till hjälp inom vårdorganisationerna och det vårdsystem vi har i vårt land, eftersom de ser diagnosen direkt kopplad till åtgärd. Man menar dock att individuell bedömning av hela livssituationen bör ligga till grund för åtgärderna, för att få till stånd en varaktig förändring.

S: Risken jag känner med diagnoser är att de kan bli begränsande på något sätt, det blir en stämpel att man är sjuk så det är inte lönt att kämpa, man blir sin diagnos.

B: De beter sig inte som de gör för att de har den diagnosen, utan för att de haft traumatiska upplevelser. Även om man får fram en diagnos så hjälper inte det.

Visst kan det hjälpa till att få hjälp i samhället vilket kan vara en lättnad, men det talar egentligen inte om varför, vad finns det för bakgrund och vad behöver den här människan för typ av hjälp.

Delar av en helhet som mål

Psykiatrins målsättning är att utreda, diagnostisera och medicinskt behandla med hjälp av psykiatriker och psykologer, men också att slussa patienten vidare till andra avdelningar och aktörer. Fokus ligger på att diagnostisera utifrån remisser samt hitta lämpliga insatser. Man menar också att det är viktigt att hålla kontinuerliga vardagliga samtalskontakter. Syftet med dessa är att ge socialt stöd och det fungerar också som en larmklocka vid uteblivna besök, för att tidigt upptäcka återfall.

P: *Man sitter ju då på tisdagarna och läser remisserna och beslutar om vad som behöver göras i första hand, utreda och medicinskt behandla är det man gör då. Parallellt ska ju socialtjänsten komma in med sin behandling.*

P: *Så vi sköter oftast deras medicinering. De flesta kommer upp varje dag och hämtar sin behandlingsmedicin, man har också sin kontaktperson här... Man kan fika och snacka lite grann och ofta så lär man känna all personal här, plus att när återfallen kommer, vare sig det ena eller det andra så märks det ju väldigt snabbt här eftersom de inte kommer och hämtar sin medicin.*

Uppfattningar om att det är svårt att rekrytera psykologer till psykiatrins beroendeenhet uttalas i diskussionen kring personalsammansättningen. Anledningen till det tror man beror på att psykologer ofta vill jobba direkt med behandling och inte bara syssla med utredningar som förberedelser till kommande behandling.

P: *Vi har budgeterat till en psykolog och har sökt psykolog länge men har inte kunnat anställa någon. Tanken med psykologen var ju delvis att han skulle jobba med utredningar så att man ska få ordentliga utredningar gjorda och kanske bara som ett led i behandlingsarbetet och jag vet inte om det är det som kanske gör det svårrekryterat. Man kanske vill jobba mer med behandling.*

Inom psykiatrin finns grundtanken att diagnoser är nödvändiga för att få rätta insatser. Man menar att en rätt satt diagnos är direkt kopplat till vilken insats som bör planeras. Inom psykiatrin anses detta vara huvuduppgiften, för att få vård inom organisationen eller senare slussa vidare till andra aktörer. Även inom socialtjänsten förekommer åsikter om diagnostisering som positivt i koppling till matchning. Diagnoser kan skapa förståelse för mänskliga beteenden, vilket kan vara en befrielse för klienten men också ge bättre förutsättningar för socialsekreteraren att kunna bedöma dennes situation.

P: *Kopplat till så gott som alla diagnoser finns ju åtgärder, sett från landstingets sida, antingen behandlingsprogram eller medicinering. Det är ju svårt att få några insatser om man inte har en diagnos.*

S: *Det finns ju en del att hämta ur det här med att ha tydliga diagnoser. Just när det gäller matchningen med behandlingen... en del kan ju känna sig hjälpta av diagnoser, har man AD/HD t.ex. och inte förstår sig på sig själva varför man flyger och far och inte kan samla ihop sig, då kan det ju kännas befriande med en diagnos.*

Samverkan

En uppfattning som vi har sett hos samtliga undersökningsspersoner är att samverkan mellan aktörerna är viktigt och i många fall avgörande för klienters behandlingsresultat. Under rubriken "Det börjar bli bättre" beskrivs befintligt samverkan som en process där dialogen ses som en förutsättning. Det handlar om att se varandras kunskap och kompetenser inom flera områden och ta vara på dem eftersom personer med missbruk och psykisk ohälsa ofta har en mångfasetterad problembild. Avsnittet tar också upp åsikter om det fungerande samverkan kring avgiftningar. Under rubriken "Mer finns att önska" uttrycks åsikter om psykiatrins tidsramar och önskningar om större flexibilitet samt bättre samverkan mellan aktörerna.

S: När personen i fråga lyckas, då tror jag det beror väldigt mycket på vår förmåga till samverkan till samarbete. Och tyvärr tycker jag att det finns väldigt mycket mer att önska.

Det börjar bli bättre

Psykiatrin menar att den samverkan som råder med socialtjänsten fungerar bra men samtidigt finns det mer att utveckla. Förändring mot det positiva har alltså skett de senaste åren och man menar att förståelsen för varandras arbetsområden, lagrum och ansvarsområden har ökat. Samverkan anser man är en process och tar tid att etablera. Grunden i ökad förståelse och samförstånd ligger i dialog. I detta avseende ser man också fördelar i att ha verksamheterna belägna nära varandra.

P: Det handlar ju om att man måste prata ihop sig, aktörerna runt omkring och att det är rätt högt till tak och att var och en vet vad de ska göra. Så där har det fungerat väldigt bra... Vi jobbar ju väldigt nära varandra... överhuvudtaget så är väl min vision ett beroendecentrum där både kommun och landsting sitter och arbetar tillsammans, åtminstone i samma byggnad.

Inom socialtjänsten finns liknande uppfattningar om en positiv förändring till samverkan med beroendeenheten.

S: Så vi försöker ha nära kontakt så det blir lätt och naturligt att ringa upp och resonera, jag har en klient med de och de problemen hur ska vi kunna samarbeta, vad kan ni göra och hur ska vi göra och så. Och det fungerar faktiskt jättebra som det är nu, att vi har upparbetade kontakter och så.

Hur socialtjänsten ser på samverkan med behandlingshemmen har vi inte fått några tydliga svar på. Det som ändå uppfattas under intervjuerna med socialtjänsten är att relationen dem emellan fungerar bra och de anser att behandlingshemmen är tillmötesgående. Vidare anser man att det finns en öppen dialog vad gäller arbete och målsättningar samt insatser.

Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrins beroendeenhet handlar mycket om avgiftningar. Här anser psykiatrin att de oplanerade avgiftningarna som förr var vanligt inte förekommer i samma utsträckning längre. De två aktörerna träffas kontinuerligt och planerar och diskuterar patienters/klienters behandling. Detta är positivt eftersom man anser att avgiftning utan en efterliggande välplanerad behandling saknar verkan.

P: *Socialtjänsten kommer upp här och man har möten varje vecka vare sig vi behöver eller inte. Vi jobbar ju väldigt nära varandra. De här orealistiska kraven på varandra är ju bortsuddade i mycket. Idag finns vi med gemensamt mycket tidigare, det är inte så att man idag ringer och vill ha en tid i morgon, ja men vi har fullt och då kunde man bråka om det. Utan nu är det så här, vi har lite funderingar, att han har kommit här och sökt bistånd och vi för diskussionerna långt tidigare.*

Mer finns att önska

Socialtjänsten uttrycker åsikter om psykiatrins långa väntetider när det gäller avgiftning. Det vore fördelaktigt med mer flexibilitet för att bättre kunna anpassa vården efter klienternas behov. Även om möten och avgiftningar planeras gemensamt är de inte alltid möjliga att genomföra pga. klientens dagsform. Man anser att missbrukares motivation, i synnerhet i samband med psykisk ohälsa, måste användas och ses som färskvara, något som hindras och försvåras av strikta tidsramar. Psykiatrin har en uppfattning om att det alltid måste finnas en långsiktig planering för klienterna när de skickas för avgiftning. Självklart vore detta optimalt, men att planera och sätta upp målsättningar tillsammans med klienten när man har ett svårt beroende kan vara problematiskt. Det önskas därför att klienter i vissa fall först skulle få genomgå en avgiftning.

S: *Ibland kan man ju tycka då att de är lite för strikta inom psykiatrin, de får en tid om tre veckor och så ska de vara där precis den tiden och då kanske de inte alls är i form att komma dit. Kanske lägga upp det på ett annat sätt för att klara möta missbrukarna och särskilt dubbeldiagnoserna som har det så kämpigt med sig själv och sin tillvaro alltid... jag skulle önska att vi kunde mötas lite mer, att de kunde bli lite mer flexibla inom sjukvården, för den här gruppen.*

S: *De säger att de bara tar in på avgiftning om det finns en planering, alltså de har någon sådan policy att när vi vill hjälpa till och lägga in någon på avgiftning så skall det finnas en planering här ifrån. De vill inte ha det här att människor går in på avgiftning och går ut och super, in på avgiftning, ut och super. Och det tycker vi är helt riktigt ju... vi kan inte prata med de missbrukande människorna när de är fulla eller drogade om en planering, för det funkar inte i deras huvud. Utan då tycker vi att de behöver komma in på avgiftning bara några dagar, sen kan vi börja snacka med dem och göra en planering.*

Önskan om samverkan efter avslutad behandling kring klienter med behov av fortsatt samtalsterapi har framkommit. Tiden i behandling är ofta snäv och för kort för att bearbeta svåra upplevelser som personer med psykisk ohälsa och missbruk ofta har med i sin historia.

B: *De flesta av våra patienter skulle behöva fortsatt samtalsterapi och fortsätta bearbeta. Om man kommer från ett missbruk så är det under ungefär en tre års period som det poppar upp saker och ting inom en, man har inte hanterat känslor utan dövat det med droger hela tiden. Innan man blir hel, stabil och kan hantera problem och relationer och så tar det mer än tre år.*

Inhyrd psykiatrisk expertkunskap skulle öka kompetensen inom socialtjänstens och behandlingshemmens verksamheter. De inhyrda resurserna skulle också fungera som en

kontakt mellan de tre olika aktörerna. Psykiatrins kunskapsområde fyller en viktig funktion i missbruksvården.

S: *Vi har ett önsketänkande som vi har pratat om mycket. Det är att vi hade en egen psykiatrisk läkare, konsultläkare knuten till vuxenheten. Och så att man hade honom eller henne som en mellanhand mellan oss och landstinget, det är ett önsketänkande.*

B: *Det finns ju oerhört mycket psykiatrin skulle kunna göra både mot våra patienter och genom att hjälpa personal vid handledning och allt möjligt. Jag tror vi skulle få ett mycket bättre resultat.*

En annan önskan som uttrycks om optimal samverkan är integrerade team där både psykiatri och socialtjänst ingår. För att greppa klientens hela problembild krävs kompetenser från alla områden och att dessa samverkar nära varandra, i integrerade team. Både missbruk och psykisk ohälsa måste tas hänsyn till samtidigt. Denna samverkan beskrivs som en framkomlig väg i arbetet med svår psykisk sjukdom och missbruk i en kommun där en av intervjupersonerna arbetar.

S: *Vi jobbar tillsammans med psykoteamet i vissa fall och där fungerar det bra. Jag får ta missbruket, psykiatrin får hjälpa till när det gäller den kompetensen och man får se vad man behöver hjälpa till med för att det ska fungera. Nu har vi plötsligt hela bilden, nu har vi inte bara fokus på missbruket. Det handlar inte bara om missbruket, självklart finns det men det finns också en psykisk sjukdom i botten och de här bitarna, dom hänger ihop. Vi kan göra situationen bättre och det tror jag bara vi kan göra tillsammans.*

P: *Man ska göra saker gemensamt. Jag tror på det här med integrerade team där socialtjänst och landsting gör saker gemensamt.*

Vad hindrar samverkan?

I vissa delar av arbetsområdet finns redan en samverkan, men önskningar om ökad samverkan har framkommit. I samverkan finns hinder av såväl ekonomisk som organisatorisk natur, vilket vi belyser under rubriken "Ekonomi och organisation hindrar samverkan". Kortsiktig planering och brist på bostäder ställer till problem i eftervården vilket beskrivs under "Långsiktighet efterfrågas".

Kunskapsbrister och olika ideologiska och traditionella synsätt sätter också käppar i samarbetshjulen, vilket behandlas under följande rubriker. Under rubriken "Kollision i synen på missbruk" behandlas olika syn på begreppet missbruk. Under "Vill inte psykiatrin ha med missbrukare att göra?" tar man upp allmänpsykiatrins handlande gentemot missbrukare med psykisk ohälsa. Stycket "Inte heller med behandlingshem?" tar upp psykiatrins samverkan med behandlingshemmen. Rubriken "Piller som lösning" beskriver uppfattningar om medicinering och stycket "Svår psykisk sjukdom, svår för vem?" behandlar begreppet svår psykisk sjukdom. Avslutningsvis under "Är sekretess inget hinder" tar vi upp synen på sekretess efter som denna ofta anses hindra samverkan mellan de olika aktörerna.

Ekonomi och organisation hindrar samverkan

Frågor kring ekonomi är ständigt förekommande inom vården eftersom pengarna måste räcka till alla. Långsiktiga lösningar för människor med dubbelsjuklighet kräver organiserad samverkan med gemensam målsättning mellan vårdaktörerna. Hinder i vården är bl.a. korta vårdtider där ekonomin styr metoder och tillvägagångssätt.

B: *Man skapar sig sina teorier utifrån pengapåsen. Jag tror det är så förföriskt det här med åtstramningarna. Och så hittar man teorier som passar utifrån hur mycket pengar man har.*

B: *Jag tycker vårdtiden ska vara mycket längre. Men från socialtjänsten framför allt skulle jag önska att i stort sett alla som kommer därifrån hade fått längre tid. Men man sparar pengar.*

Även långa beslutandeprocesser inom organisationerna kan utgöra hinder. Denna tröghet kan sätta hinder på individnivå där motivation och medbestämmande många gånger är avgörande för förändring. För den enskilde socialsekreteraren med relation till klienten upplevs denna tröghet som frustrerande och som ett hinder i konstruktivt klientarbete. Distansen mellan beslutsfattande och klienten leder lätt till att besluten tas på ekonomiska grunder. Förståelse för den enskildes situation ligger inte i första hand till grund för de beslut som tas om åtgärder och individen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

S: *Så fort jag ska höja ögonbrynen eller gå utanför det här rummet så måste jag helt enkelt förankra det någon annanstans, det blir en tröghet i systemet... att säga till en kille som är motiverad i dag när han kommer upp att, ja jag får se vad vi kan göra för någonting. Det kommer åtminstone att ta en månad från nu... om jag gör bedömningen, måste jag via en utredning och via beslut gå till arbetsutskottet sen är det ju de som måste avgöra. Dom har ju inte träffat den här killen överhuvudtaget och kommer inte att träffa honom på sammanträdet heller. Så det är ju på de grunderna man fattar besluten. Alltså var landar det någonstans? Det går inte att jobba på det sättet överhuvudtaget, motivation är i allra högsta grad färskvara. Sen är det ju så att nämnden har begränsat med pengar och det beror ju så klart också på hur mycket man är beredd att satsa från kommun till kommun.*

Den tröghet man talar om inom socialtjänsten är något som de utifrån också tycks se hos psykiatri. Beslutsgången är ett hinder, där beslutande och behandlande psykiatripersonal har olika syn på vårdbehov i enskilda fall.

S: *Det är svårt att tränga igenom det här, för att besluten om den här personen ska få hjälp styrs ju ofta uppifrån i någon sorts team, de styrs mycket ovanifrån. Alltså att det är en organisatorisk fråga då någonstans. Men kommer vi ner lite längre i hierarkin och pratar med enskilda handläggare som är styrd av organisationen tycker jag att vi möter lite andra attityder och en större förståelse.*

De avgörande besluten tas ofta på ekonomiska grunder snarare än klientens behov. Beslutande personer inom organisationen har inte alltid kunskap om klientens helhetsperspektiv, vilket leder till kortsiktiga lösningar. Det är sällan kommunerna har något eget bra behandlingsalternativ. Kommunerna borde fokusera på eftervård och lämna behandling åt

dem som har mer kunskap om detta, vilket skulle bli billigare på längre sikt. Detta överensstämmer med socialstyrelsens riktlinjer för kommunerna, menar behandlingshemmen.

B: *Om man lever som kriminell narkoman t.ex., så har du ju bara umgänge med kriminella narkomaner och det har du kanske haft i femton år bakåt. Då behöver man ju bryta hela sitt livsmönster, för att få en chans. Men då fokuserar man på att hålla nere kostnaderna och försöker behandla på hemmaplan. Man har dålig kunskap om problematiken. Man borde egentligen skicka iväg, så att man bryter mönster, sen borde kommunerna fokusera på att bli bra på att ta tillbaka dem och hjälpa till med bostad, jobb och sysselsättning osv. Men då är det ju alltid någon politiker, och vad vet politiker om detta. Det är inte fel att tänka ekonomiskt, men gör då det som är billigast på längre sikt.*

B: *Socialstyrelsens riktlinjer är att kommunerna får pengar om de är duktiga på eftervården, men ofta kan de inte visa upp några bra program. Så det finns ju klara direktiv uppifrån och där vet man och har bredare kunskap. Man har gjort undersökningar, forskning och går ut med direktiv till kommunerna.*

Kortsiktighet

Ett problem i samverkan med socialtjänsten är synen på långsiktighet och helhet vad gäller behandling, menar behandlingshemmen. De menar att tiden på institutionerna är för kort vilket på sikt inte ger det resultat man önskar. Förändringsprocessen när det gäller människor med missbruk och psykisk ohälsa kräver långa tidsperspektiv. Socialtjänstens syn på behandling som snabba lösningar är inte förenligt med varaktig förändring. Det anses också att den kortsiktiga planeringen syns efter avslutad behandling, då brister i eftervården är tydliga. Behandling på institution är ofta inte tillräckligt utan det stora arbetet ligger trots allt i långsiktig planering på hemmaplan.

B: *Det är precis som man köper sig fri från problem. Man skickar iväg dem på behandlingshem, sen förväntar man sig att personen ska komma hem och vara frisk. Det är efter en behandling som det verkliga jobbet börjar, det är när man ska möta det verkliga livet.*

De intervjuade inom socialtjänsten tar också upp problemet med vården efter en behandlingshemsvistelse. Intervjupersonerna framhåller att en av orsakerna till luckor i eftervården handlar om boende. Man lägger mycket tid på och anstränger sig för att försöka lösa boendefrågan för klienterna, men det är svårt att få tag på lägenheter. De glapp som uppstår mellan boendet på behandlingshem och i hemkommunen kan ställa till stora problem för dessa människor.

S: *Många utav dom som vi skickas till behandling saknar bostad, de kanske har haft bostad, kanske bränt sina bostäder, alla våra hyresvärdar utan undantag i kommunen vill ju inte befatta sig alls med denna kategori av människor. Det är jättesvårt och få lägenhet, så det här är ju ett problem.*

S: *Ett jättestort hinder är ju att hitta lämplig bostad. Jag tror att vi pratar dagligen, använder några timmar dagligen åt att prata om boende. Människor som är bostadslösa eller bor på ett sätt som inte är så bra, behöver ett annat boende. Det finns ju inget boende så utan man får ställa sig i kö och vänta och*

vänta. Och sen stökar de till det, de blir sjuka och tar inte sina tabletter, får spelet och stökar till det.

Kollision i synen på missbruk

Synen på missbruk och beroende är inte entydig. Vissa åsikter har framkommit att det är möjligt att efter avslutat missbruk lära sig hantera alkohol på ett kontrollerat sätt. Här finns tankar om missbruk som en kunskapsfråga, vilket också direkt motsägs av andra åsikter. Däremot är man överens angående beroende, där det inte är möjligt att lära sig måttligt drickande.

B: *För det mesta är inte patientens målsättning densamma som våran. Den skiljer sig ofta ganska stort. De har ofta en vanföreställning om att hålla färgen genom behandling men sen ska ut och dricka lite socialt bara jag får lite hjälp att skära ner, de har mycket föreställningar om detta.*

P: *För många är ju missbrukare och man kan mycket väl lära sig att hantera alkoholen senare i livet, att man mer differentierat bilden. Att missbruk kan man ju ha i en del av sitt liv, men sen lära sig att hantera. För de dricker tokigt. Men har du en beroendeproblematik så förr eller senare får du ett sånt där kraftigt återfall. Där talar man ju aldrig kontrollerat drickande, det skulle man ju aldrig som behandlare rekommendera. På så vis har ju diagnoserna varit jättebra tycker jag, för tidigare behandlade man alla som om de var beroende och så visade det ju sig att vissa klarade ju att dricka sedermera vilket satt igång processer hos alla.*

Vill inte psykiatrin ha med missbrukare att göra?

Där beroendeenheter inom psykiatrin finns fungerar samverkan för det mesta tillfredställande, anser behandlingshemmen och socialtjänsten. Det finns också uppfattningar om att psykiatrins arbete och samverkan med övriga aktörer fungerar annorlunda än vad man önskar. Någon anser att anledningen till varför detta inte fungerar är det faktum att allmän och allmänpsykiatrin inte vill arbeta med missbruk eftersom man påstår sig inte ha kompetens när det gäller missbruksbehandling. Här menar man att okunskapen i vissa fall föder någon slags rädsla som skapar hinder för samverkan kring missbrukare med psykisk ohälsa.

S: *Allmänpsykiatrin befattar sig inte med missbrukare och missbruksproblematik överhuvudtaget. Skulle det komma en remiss till psykiatriska öppenvården där det framgår att personen har en missbruksproblematik som ligger i historien så blir den nästan automatiskt hänvisad till annan instans. Det man då säger ifrån psykiatrins sida är att man inte har kompetens i de här frågorna. Och då tycker ju jag att man fokuserar väldigt mycket just på det här med missbruket. Så som om missbrukare i alla andra avseenden skulle vara så förfärligt mycket annorlunda än alla andra människor. Varför kan man inte närma sig dom, utifrån det som gäller alla oss människor oavsett vad vi drabbats av.*

B: *Är det inte akutsituationer så vill inte psykiatrin ha med oss eller våra patienter att göra, eller har inte resurser till det, vilket det är vet jag inte.*

Inte heller med behandlingshem?

Psykiatrin ser inte ett direkt samverkan med behandlingshemmen som nödvändigt eller naturligt eftersom socialtjänsten i de flesta fall fungerar som en länk mellan de båda. Vidare

menar man att socialtjänstens uppgift är ofta att förmedla och skapa kontakter åt klienten mellan de olika behandlingsinsatserna. Samtidigt menar man att alla patienter inte vill ha medicinsk hjälp.

P: Där har vi ju inte kontakt, för det brukar ju nästan alltid socialtjänsten ha. Idag är det väl kanske så att det hänger på den enskilda socialsekreteraren, jag vet inte. Men jag tycker vi är med en hel del och då är vi väl inbjudna av socialtjänsten, och man måste ju vara inbjuden av patienten själv, det får man ju aldrig glömma va. För det är ju inte alltid som de vill ha kontakt med psykiatrin. Det här med medicinering är ju inte alla intresserade av heller.

Piller som lösning

Andra synpunkter på brister inom psykiatrin är att deras arbete oftast begränsas till medicinska åtgärder på problem orsakade av bakomvarande händelser. Samtal om problemens orsaker förekommer alltför sällan, man ser bara problemens symptom och medicinerar sedan där efter. Här menar man att bristen på psykologer inom psykiatrin är en av anledningarna till detta. Någon anser vidare att psykiatrin i vissa fall också försämrar klientens situation pga. övertro på mediciner. Utifrån dessa resonemang tycker behandlingshemmen att behovet av kontakt med psykiatrin är minimalt och endast nödvändigt vid akuta situationer som exempelvis vid svåra psykotiska tillstånd. Inom behandlingshemmen löser man istället ofta behovet av psykiatrisk kompetens internt.

B: Hon fick Xanor utskrivet det första hon fick, det är det mest beroendeframkallande läkemedlet. Alltså, det fungerar skitbra direkt, du mår bra direkt, ett piller och all ångest och allt är borta. Det är därför det är så farligt. Och där kan jag tycka att psykiatrin är helt ute och simmar. Jag tycker att man ska ha så lite med psykiatrin att göra som möjligt. De får tabletter va, varför åker våra klienter in, den enda anledningen är att de vill ha piller.

B: Grejen är den att ha möjlighet att lyssna på folk. Det skrivs ut läkemedel av läkare som inte ens träffar klienten. Det är ju inte klokt. De har väl med tid, kostnader, effektivisering. Alla psykoterapeuter försvinner ju. Man satsar ju inga pengar på det här längre. Det finns ju inte många psykologer kopplade längre. Terapi det får ju inte patienterna inom psykiatrin längre.

B: De ser det mer biologiska, att lösa deras problem med piller att det hela tiden har med substanser i hjärnan att göra, lösningen är tabletter, mediciner... Ibland är vi jätteberoende av psykiatrin, när vi måste köra in dem när det är psykosor och så, vid akuta extremfall.

Svår psykisk sjukdom, svår för vem?

Uppfattningar om att man måste vara tillräckligt sjuk för att få hjälp med sina känslomässiga problem har framkommit. Resurserna och vårdplatserna har minskat, vilket innebär att fler människor med psykisk ohälsa tvingas hantera detta på andra sätt än via psykiatrin. Det räcker inte att man mår psykiskt dåligt utan man måste lida av svår psykisk sjukdom för att hjälpen skall erbjudas. Begreppet svår psykisk sjukdom ifrågasätts, där man menar att diagnosen inte nödvändigtvis säger något om graden av lidande eller hur akut vårdbehovet är.

B: De är väl inte tillräckligt sjuka för psykiatrin, som man bedömer där. Hade jag fått bestämma hade vi haft mer psykiatri. Vi har ju skurit ner psykiatrin, eller vårdplatserna rätt kraftigt, och då kan man bara ta de allra svåraste. Vi har ju haft patienter som tagit livet av sig efter behandling, och då kan man tycka i efterhand att de skulle ha fått mer hjälp på hemmaplan.

B: Man pratar om svår psykisk ohälsa, då ska det ju vara schizofreni eller psykotiska tillstånd eller svåra personlighetsstörningar. Svår för vem? Jag menar, den som är svårt deprimerad och försöker ta livet av sig en massa gånger, så kan den uppleva det minst lika svårt som den som är schizofren.

B: Man får inte den vidare hjälpen pga. resursbrist, och då menar man att man bara tar de som är absolut akut självmordsbenägna och har psykos. Kommer det då någon och säger att jag mår dåligt och har ångest, ja, så... Ja, du hamnar kanske i en kö på tre år därför att ditt problem inte anses akut.

Är sekretess ett hinder?

En fråga som ställdes under intervjuerna var: Är sekretessen mellan framförallt psykiatrin och socialtjänsten ett hinder för samverkan? Det som framkom var att sekretessen inte utgör något hinder om man har klientens tillåtelse till samverkan. Det finns också en lag som häver sekretessen om den berörda individen har ett missbruk (Se bilaga 2).

S: Nä, det finns ju en paragraf som säger att om en människa har långvarigt pågående missbruk så får vi bryta sekretessen för att hjälpa klienten på bästa sätt, i både LVM och SoL fall.

Teoretisk problematisering

I resultatredovisningen har flera tankar med koppling till de teorier som ligger till grund för vårt arbete framkommit. Vi ska nu med hjälp av Habermas, Meads och Antonovskys teoribildningar problematisera och belysa samt relatera till de åsikter och uppfattningar som framkommit under intervjuerna.

Vid intervjuerna framkommer tankar om olika traditioner och det talas om olika förhållningssätt. De tre aktörerna talar inte alltid samma språk. I ena fallet är det organiserat och rationellt tänkande som råder, där klienten får anpassa sig efter hur vårdapparaten är organiserad. I andra fallet finns klienten i centrum och viljan finns att söka upp och erbjuda vård som anpassas till den enskildes situation och förutsättningar. Habermas talar om system och livsvärld, där systemets logik ordnar och organiserar för att generera effektivitet och pengar. Livsvärldens kommunikativa handlande och interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare, som föder samförstånd och självständighet, har bytts till systemets logik, där vårdgivare har tolkningsföreträde ang. behov och insats hos den enskilde individen. Den gemensamma förståelsen som föds ur kommunikation får stå tillbaka för organisationens krav på effektivitet.

Enligt Meads tankar kan vi möta människor ur olika perspektiv och med olika förhållningssätt. Ur ett punktuellt perspektiv ser vi vad en människa är och vi låter hennes bakgrund, handlanden och historia ge oss bilden av hennes identitet. Med ett relationellt perspektiv blir inte det väsentligt att se vad en människa är utan vem hon är. Fokus ligger på

relationen och den gemensamma utveckling som kommer ur denna. Genom ett relationellt perspektiv blir det viktiga i arbetet med människors förändring att möta dem, se vem de är och hjälpa dem upptäcka möjligheten till förändring oavsett deras historia. Vad en person är finns alltid med i möten mellan människor, men med ett relationellt bemötande ligger fokus på vem hon är och vem hon kan bli. Med detta perspektiv blir klienten delaktig i sin egen förändring och får genom relation med behandlande personal hjälp att upptäcka sina möjligheter.

Enligt Meads teorier är vi beroende av relationer för att utvecklas och förändras. Ser vi styckena "helhet som mål" och "delar av helhet som mål" ur dessa perspektiv blir bilden tydlig. Med målsättning att beröra helheten utifrån klientens livssituation läggs fokus på att genom relation och dialog se vem klienten är och kan bli. Förutsättning för förändring ligger i relation och samförstånd mellan aktörerna, men också mellan vårdtagare och vårdgivare. Förändringen kommer ur ett gemensamt meningsskapande. Diagnostisering ger en bild av vad en individ är snarare än vem. Det ger inte svar på vare sig vilja eller förmåga till förändring av svåra livssituationer. Detta perspektiv lokaliserar det sjuka och ger inte lika stort utrymme för det friska att utvecklas. För människor med svår psykisk sjukdom, som exempelvis schizofreni, kan medicinering dock vara nödvändig för att samla ihop personen och överhuvudtaget skapa möjlighet till positiv förändring. Diagnoser kan också vara en hjälp och ett verktyg i kommunikation och matchning, men ger ingen hel bild av individens livssituation.

Antonovsky anser att man bör vända på tanken och istället för att se det sjuka bör man se det friska och möjligheterna till förändring dessa ger. Genom relation med klienten finns möjligheten att skapa mening och sammanhang i den ofta kaotiska värld dessa lever i, vilket också ger förutsättningar för både vilja och motivation till förändring. Möjligheter till förändring kommer alltså ur att förstå och se möjligheter att hantera och finna mening i de situationer man lever i. Samtidigt kan människor, med hjälp av diagnoser, få större förståelse för sina egna irrationella handlanden. Denna förståelse kan också skapa mening, motivation och vilja till förändringsarbete och kan underlätta kommunikation mellan klient och behandlare. Antonovsky menar att ökad förståelse och begriplighet om varför man reagerar på sin omgivning som man gör ger större tilltro till förändring av egna beteenden.

Människor är sociala varelser och är i behov av tillhörighet och gemenskap med andra för att utvecklas, menar Mead. Det är en förutsättning att vi förstår och ser mening i det vi själva gör och i andras handlanden för att kunna ingå i detta samspel. Vi är inte fristående och oberoende av andra. Detta gäller även professionella personer som arbetar med människor. Genom relation skapas förståelse för individens handlande, såväl som för dennes sätt att tänka. I resultatavsnittet "det börjar bli bättre" finns önskan om ökad samverkan. Förutsättningen för god samverkan är förståelse, vilket även gäller mellan personal från olika organisationer med samma mål, vilket är klientens väl. För att nå målen inom missbruksvården måste de olika aktörerna förstå varandras målsättning och arbetsgång. Relationen mellan de olika aktörerna kan delvis beskrivas som punktuell, där man ser varandra utifrån vad man är snarare än vem man är. Styrkan i samverkan hindras av att resurserna inte synliggörs mellan aktörerna. Vägen till ett gemensamt mål och mening i arbetet förutsätter kommunikation, något som uttryckts i intervjuerna. Mead uttrycker detta samspel som en *kommunikativ process av meningsskapande*.

I stycket "ekonomi och organisation hindrar samverkan" beskrivs bl.a. organisationen och beslutsfattandet som hinder i arbetet med utsatta människor. Även här kan Habermas tankar om livsvärld och system vara relevanta. Organisationerna i vilka intervjupersonerna arbetar

styrts och organiseras av människor med distans till det direkta arbetet med människor. Distansen till den enskilda och utsatta individen lägger hinder för förståelsen av behov, vilket bl.a. beskrivs som tröghet i systemet. Trögheten skapar frustration och känsla av maktlöshet hos personalen. De ser ofta behoven och möjligheter till förändring hos klienten, men blir begränsade i sitt arbete av organisation och budget. Trögheten i systemet påverkar även klienten negativt i sin strävan till förändring. I svåra och utsatta situationer är möjligheten att själv påverka skeenden av stor vikt, menar Antonovsky. Genom engagemang och möjlighet att själv påverka sin framtid skapas meningsfullhet, motivation och vilja till att våga satsa på förändring. Detta i kombination med att se sammanhangen i det som sker och se resurser till att förändra ger en känsla av mening och sammanhang som är nödvändig för att kunna må bra. Den beslutsgång om eventuella insatser för den enskilde klienten inom socialtjänsten som beskrivs i resultatet ger inte goda förutsättningar för hög motivation till förändring hos missbrukare som lider av psykisk ohälsa.

Behandlingshemmen anser i stycket "långsiktighet efterfrågas" att förändring av svåra livssituationer kräver tid. Ur systemets perspektiv är tid pengar, menar Habermas. Bristen på förståelse för missbrukare med psykisk ohälsa och distansen från den enskilde individen låter lätt effektivitet styra i beslut om åtgärder. Förändringsprocesser är ofta tidskrävande om ett långsiktigt resultat för den enskilda människan skall uppnås. Här kolliderar systemets krav på effektivitet och ekonomiska tänkande med livsvärldens behov av relationer och meningsskapande för att åstadkomma god förändring. Habermas varnar för riskerna med att ensidigt låta systemets logik styra. Det medför att människor mer och mer förlorar sin frihet och självständighet som kunskapande och fritt handlande individer, vilket också försvårar den kommunikativa förståelsen och meningsskapandet. Systemet finns och måste finnas men livsvärldens logik/ kommunikationen måste tillåtas verka i systemet för att inte orsaka negativa konsekvenser för människor.

Diskussion

Metoddiskussion

Vi har valt den hermeneutiska traditionen som utgångspunkt och kvalitativ metod för vår undersökning, för att med hjälp av intervjupersonernas upplevelser och åsikter få ökad kunskap och förståelse för problemområdet. Avsikten var inte att hitta några absoluta sanningar utan att belysa gemensamma såväl som olika synsätt på vård av missbrukare med psykisk ohälsa. Vi anser att vårt arbete har gett oss ökad förståelse och kunskap och flera olika infallsvinklar vi tidigare inte såg. Vi tycker att våra frågor utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade på ett tillfredställande sätt. I våra intervjuer träffade vi de undersökningspersoner vi önskade utifrån vårt problemområde. Samtliga hade lång erfarenhet och många synpunkter på området. Detta område menar intervjupersonerna är komplext och kan ses ur många olika infallsvinklar, något som också visat sig i vårt arbete.

När man gör kvalitativa undersökningar är det viktigt att få bra kontakt med intervjupersonerna, vilket vi menar att vi fick. Alla var mycket engagerade och uttryckte att detta är viktiga frågor som man kan diskutera kring länge. Vårt mål var att ställa frågor som skulle locka intervjupersonerna att uttrycka sina personliga åsikter kring våra teman. Det kan i en intervjusituation vara svårt att svara uppriktig och självkritisk, men vår uppfattning är att de på ett ärligt sätt diskuterade och uttryckte sina åsikter och tankar om arbetet kring människor med missbruk och psykisk ohälsa. De intervjuade personerna, liksom alla

människor, är olika och uttrycker sig på olika sätt, där en del är mer frispråkiga och vassa i sina formuleringar och andra mer neutrala och mjuka.

Vi använde oss av semistrukturerade frågor utifrån våra teman vilket vi tror gjorde efterarbetet lite svårare än om vi använt oss av strukturerade frågor. Vi tror att vårt resultat fick ett annat djup genom att vi mer fritt diskuterade och följde intervjupersonernas tankebanor. Vårt förarbete med tematisering och pilotintervju gick att genomföra utan större problem. Ett kvitto på att våra förberedelser var bra, är att alla intervjuerna överlag gav svar på de frågor vi önskade få besvarade. Vi behövde inte omarbete temapunkterna efterhand utan de såg oförändrade ut genom intervjuerna. Det är en konst att intervjua människor och det finns många fällor man kan hamna i. En sådan fälla är att ställa slutna frågor där man får ja och nej till svar, vilket vi delvis gjorde. Detta upptäckte vi när vi senare började bearbeta resultatet. En annan risk med att enbart diskutera fritt utifrån teman är att man lätt hamnar utanför problemområdena och då missar betydelsefulla delar. Detta problem uppstod när vi intervjuade socialtjänsten och psykiatrin i frågan om deras syn på samverkan med behandlingshemmen. Där fick vi deras åsikter men vi kan i efterhand se att det fanns mer att diskutera.

Avsikten med vår undersökning var att belysa de tre aktörerna i samma omfattning för att se deras syn på varandra och kopplingar dem emellan. Resultatet blev dock lite annorlunda, eftersom de flesta uppfattningarna och synpunkterna som framkom berörde samverkan och synen på psykiatris verksamhet. Anledningen till detta kan delvis vara vår förförståelse och vårt sätt att genomföra intervjuerna på. Men den huvudsakliga orsaken till detta anser vi ligga i de olika synsätten man har, där intervjupersonerna från psykiatrin skiljer sig vad gäller behandling av missbrukare med psykisk ohälsa. Vi ska i följande delar av diskussionen ta upp våra uppfattningar om de olika resultatdelarna, för att avslutningsvis sammanfatta hur vi ser på de bakomliggande orsakerna till varför samverkan ser ut som det gör.

Resultatdiskussion

Har psykiatrin skygglappar?

Det framkommer vid intervjuerna att missbrukare med psykisk ohälsa oftast har haft svåra upplevelser och stökig uppväxt. Oavsett vilket synsätt man har och från vilken organisation man kommer, bortser man inte från dessa faktorer som delar av orsak till individens situation, enligt våra intervjupersoner. Trots detta förordar psykiatrin enbart diagnostisering och medicinering som huvudåtgärd i sin del av arbetet. Diagnoser och medicinering bör ses i ett större behandlingssammanhang för att skapa helhet i förändring av klientens livssituation. Även om man är symptomfri med hjälp av mediciner och hjälpligt klarar sin tillvaro och livssituation tror vi det krävs mer bearbetning av känslor såväl som reaktioner på omgivningen, beteenden, relationer, och sociala strukturer. Detta för att skapa insikt, förståelse och mening i tillvaron för att på längre sikt bibehålla förändringen. Att man inom psykiatrin inte ser behovet av psykologer och terapeuter som nödvändiga i arbetet med missbrukare med psykisk ohälsa förvånar oss. Intervjupersonerna från psykiatrin uttrycker behov av psykolog i samband med utredningar men inte i bearbetande syfte. Vi upplever inte psykiatrin motvillig till bearbetande av klienters aktuella livssituation, men vi upplever att de inte ser det som sin uppgift. Behoven av bearbetning efter avslutad behandling i eftervården är uppenbara tycker vi, vilket också framkommer tydligt under intervjuerna.

En uppfattning som beskrivs är att klienter med missbruk och psykisk ohälsa ”faller mellan stolarna”. Man menar att de missbrukare som inte har en tillräckligt svår psykisk sjukdom faller utanför psykiatriens ramar. I resultatet beskrivs hur man på beroendeenheten lämnar vidare till allmänpsykiatrien vid ångest och depression. Från socialtjänsten menar man att allmänpsykiatrien inte tar emot personer med missbruk. Oavsett om missbruket är aktivt eller finns i historien skickar man dem vidare till beroendeenheten. Detta innebär att missbrukare med ångest och depressioner inte har någonstans att vända sig för att få hjälp.

Vi menar som beskrivs i resultatdelen ”svår för vem” att det bör vara individuell bedömning, där man utgår från tillståndet oavsett historia. En person med missbruk som lider av ångest och depression kan ha lika svåra känslomässiga upplevelser och problem som någon med allvarlig psykisk sjukdom. I den kanadensiska undersökningen av Dobkin m fl. (2001) framkommer att klienters oro, ångest och depression negativt påverkar beslutsamhet och koncentration på förändring. Detta innebär att om allmänpsykiatrien i dessa kommuner hade tagit sig an människor med mindre allvarlig psykisk problematik och missbruk, hade dessa haft bättre förutsättningar att fokusera på och bibehålla fokus på förändringsmålen.

I resultatet framkommer tankar om avgiftning där psykiatrien menar att planering kring klienten måste vara gjord innan man kan påbörja avgiftningsprocessen. Det är lätt att förstå psykiatriens åsikt i frågan om man inte ser avgiftningen som en del av en helhet. Kommer det in en patient för behandling och återkommer i samma skick efter någon månad så kan det verka meningslöst, vilket det självklart skulle kunna vara och säkert ibland också är. Det kan också vara så att man under denna månad har lyckats nyktra till och exempelvis planerat en behandling tillsammans med socialtjänsten, eller börjar få ordning på sitt liv men fallit tillbaka till den gamla livsstilen. Som socialtjänsten uttrycker saken, är det svårt och ibland omöjligt för individen att under ett svårt missbruk och med ett beroende planera ett förändringsarbete, se framåt och tänka klart. Vi tycker det vore önskvärt att man såg till varje individs behov och därefter tog sina beslut. Lösningen ligger i bättre kommunikation och förståelse mellan socialtjänsten och psykiatrien där man sätter klientens behov i första hand. Den policy som verkar finnas inom psykiatrien hindrar samverkan och i vissa fall försvårar klientens förändringsarbete.

Vad som framkommit i resultatet är att man inom öppenvården och allmänpsykiatrien inte arbetar med människor som har eller har haft ett missbruk. Vi kan förstå att människor med ett tungt aktivt missbruk skickas vidare till beroendeenheten eftersom de har mer kompetens kring beroende och möjligheter till avgiftning. Det som verkar helt ologiskt och märkligt är att man inte vill ta emot dem som har ett missbruk i historien. Detta kan t.ex. innebära att man efter avslutad behandling inte får någon fortsatt hjälp på hemmaplan utan måste skickas till beroendeenheten som kan ligga på flera mils avstånd. En fråga som framkom var: *Varför kan man inte närma sig dom, utifrån det som gäller alla oss människor oavsett vad vi drabbats av.* Ser verkligen alltid en missbrukares psykiska problematik så enormt annorlunda ut att man inte ens under rena perioder kan få hjälp med sina besvär? Vad beror det på att man resonerar så? Är det okunskap, rädsla, människosyn, ekonomi, organisation eller kanske en blandning av dessa?

Orsaker till samsjuklighet och stigmatisering

Intervjupersonerna menar att begreppet samsjuklighet är lämpligare att använda än dubbeldiagnos eftersom det på ett bättre sätt beskriver verkligheten då missbrukare med psykisk ohälsa oftast lider av fler åkommor än två.

I undersökningen framkommer det som tidigare bekräftats i litteratur och forskning angående orsaker till missbruk och psykisk ohälsa. Någon generell förklaring finns inte att få. Alla har en historia som på ett eller annat sätt påverkar de situationer man befinner sig i. Däremot är det entydigt att de flesta missbrukare också mer eller mindre lider av psykisk ohälsa av något slag. Viss del av dessa har också en diagnos på svår psykisk sjukdom, men långt ifrån alla har fått namn på sitt psykiska lidande. Diagnoser kan vara till stor hjälp i matchning av behandling och kan också öka klientens förståelse för sina egna beteenden och tankar. I viss mån kan diagnoser underlätta för behandlingspersonal att se och förstå beteenden hos klienten.

Det ligger trots detta en fara i diagnoser anser vi. Ur klientens perspektiv finns risken att diagnosen blir ett hinder för att se de möjligheter och det egna ansvaret för förändring man trots allt har. Om diagnosen sätts i centrum blir lätt förändringspotentialen lidande och personen blir betraktad utifrån sina svagheter och det sjuka snarare än från sina styrkor och det friska. Detta synsätt blir lätt stigmatiserande och objektiverande eftersom individens vem inte kommer i fokus utan brister och svagheter tar en central plats i identiteten.

De förstår inte varandra

Frustrationen är tydlig hos behandlingshemmen angående korta behandlingstider och få möjligheter för klienten att fortsätta sin bearbetning efter avslutad behandling. Förändring av svåra livssituationer tar betydligt längre tid än samhället är villigt att acceptera, menar de. Socialtjänstens personal är medvetna om problemen men kan inte agera långsiktigt pga. politiska beslut och stram budget. I detta avseende tycker vi att Habermas tankar om system och livsvärld passar väl in. Han menar att den kommunikativa förståelsen lätt får ge vika för effektivisering, pengar och makt. I undersökningen talas om tröghet i systemet lika väl som olika traditioner och förhållningssätt. Vårt samhälle är organiserat och måste så vara för att fungera. Men när kommunikationen och dialogen uteblir hamnar lätt fokus på pengar och effektivitet snarare än mänskliga behov. Detta skapar den tröghet som nämns i resultatet.

Samhället organiserar vården inom sjukvård/landsting och omsorgen genom socialtjänsten i kommunen. I dessa organisationer råder olika traditioner och synsätt på missbruksvården och olika förhållningssätt till klienten. De båda traditionerna står på olika grunder, menar vi. Psykiatri, som är en del av sjukvården, har sin grund i den naturvetenskapliga/läkarvetenskapliga skolan, där det centrala är att beskriva sanningar utifrån det observerbara i vår värld. Socialtjänst och behandlingshem har sin grund i humanvetenskap/ hermeneutiken som syftar till förståelse av hur människor upplever sin livsvärld. Vi upplever att dessa olika traditioner ligger som grund för de olika synsätt och förhållningssätt som försvårar samverkan mellan aktörerna.

Psykiatriens beroendeenhet ger uttryck för ett medicinskt synsätt, som vi uppfattar det utifrån resultatet. Fokus ligger på uppdraget att med hjälp av diagnoser och medicin bota och ta bort symtomen samt återställa det sjuka snarare än att se till den hjälpsökandes hela livssituation, målsättning och behov. Vården av missbrukare med psykisk ohälsa ses i separata delar mer än helhet. När uppdraget är klart lämnar man över till andra aktörer att ansvara för resten av delarna. Psykiatri ser helheten ur ett annat perspektiv än de två övriga aktörerna. Man menar förvisso att hela livssituationen måste inbegripas i förändringen, men man ansvarar endast för den medicinska delen. Ser man uppdraget slutfört efter avslutad medicinsk behandling lämnas de övriga delarna till någon annan. Socialtjänst och behandlingshem har en annan tradition och ett annat synsätt där klientens hela livssituation blir fokus för uppdraget. Vi menar att för att uppnå långsiktig förändring krävs ett gemensamt synsätt där alla aktörer ser förändring av

klientens hela livssituation som sitt uppdrag. Vården av missbrukare och i synnerhet när psykisk ohälsa finns med i bilden, kräver långsiktighet och kontinuitet där allas kompetenser sammanfogas och samverkar till långsiktiga lösningar.

Psykiatrins kompetens är viktig för att skapa förståelse och för att få rätt behandling. Behandlingen i sig är viktig för att kunna starta förändringsprocesser och börja bearbeta sin livssituation och socialtjänsten är viktig för att samordna och skapa möjligheter för fortsatt förändring efter avslutad behandling. De förändringsprocesser som påbörjats under behandling blir sällan färdiga under behandlingstiden eftersom tiden är för kort pga. kommunernas ekonomi. Psykiatrins beroendeenhet påstår sig inte erbjuda samtalsterapi i eftervården eftersom eventuella psykologer eller terapeuter inte sysslar med behandling utan utreder och diagnostiserar. Andra uppfattningar som framkommit är att allmänpsykiatri inte vill hantera frågor kring missbruk eller saknar kompetens för det. Om det beror på ekonomi eller något annat ges inget svar på i intervjuerna, men uppfattningar finns att man anpassar vårdmodeller efter pengapåsen. Behöver man hjälp från psykolog eller terapeut får man vända sig till de privata alternativ som finns, vilket få missbrukare har råd med. Som vi upplever situationen idag går klienten via diagnostisering och medicinering om så behövs, vidare till behandling under en kortare tid och sedan hem utan möjligheter att fullfölja sin förändring. Långsiktig förändring slutar inte efter behandling utan måste underhållas, stötts och motiveras under lång tid. Detta för att skapa en kontinuitet och inte hamna i den cirkelrörelse vi på många håll ser idag.

Steg i rätt riktning

Vi tror att ACT, där man med relativt enkla medel arbetar med klienter, är framtiden inom vården av personer med samsjuklighet. Forskning och undersökningar visar att samverkan över gränserna, som ACT bl.a. innebär, är svaret till lyckad behandling. Arbete på lång sikt med kontinuitet och helhet som grundpelare minskar de glapp som ofta orsakar att klienter tappat sin motivation och återfaller till den gamla destruktiva livsstilen. Detta innefattas även i vårdkedjemodellen som beskrivs av Wärmegård (2005). Vikten av kontinuitet och överbryggande mellan olika insatser beskriver också Duroy m.fl. (2003) i sin undersökning. En av vinsterna med att använda sig av ACT och case management är att klienten och case managern har tid och möjlighet att skapa en tillitsfull relation som kan bestå över tid. Det sociala stöd som relationen medför är också mycket viktigt för att kunna bibehålla sina gjorda framsteg mot ett drogfritt liv, menar Dobkin m.fl. (2001).

En positiv förändring för de som lider av svår psykisk sjukdom och missbruk är det arbete som vissa kommuner startat. Vi tror att vägen till god behandling är det samverkan som beskrivs mellan socialtjänsten och psykiatrins psykosteam i resultatet. Deras målgrupp är klienter/patienter som lider av bl.a. schizofreni och missbruk. Verksamheten är igång och under utveckling för att i framtiden kunna arbeta med klientens hela problembild. De kommer att få hjälp med sina psykiatriska problem och med sitt missbruk samt hjälp med praktiska och sociala bitar i form av boendestöd med anställd personal.

Psykiatireformen som genomfördes i mitten av 90-talet innebar att man skar ner antalet vårdplatser för de med svår psykisk sjukdom. En fråga vi ställer oss är om institutionsmodellen är tillbaka om än i ny tappning? Utifrån statistik och utifrån det som Berny beskriver i inledningen finns det ett stort antal människor som faller utanför vårdapparaten. Den positiva verksamheten som vi beskriver kommer att erbjuda fem vårdplatser, vilket enligt socialsekreteraren inte på långa vägar motsvarar de verkliga

behoven. Intressant är också att det har gått ca tio år innan man fick upp ögonen för möjligheten till boendestöd i denna form.

För att få till stånd en förändring tror vi att samverkan på gräsrotsnivå kan vara det som öppnar upp ögonen på beslutande organ. När man samverkar och visar på goda behandlingsresultat blir det svårt för dem som styr och beslutar att blunda för andra uppfattningar och synsätt. Det måste till en förändring, där man lär sig att kommunicera över gränserna och vi tror att lösningen ligger i en väl fungerande dialog.

Sammanfattningsvis menar vi att utifrån vår undersökning att missbrukare med psykisk ohälsa förekommer i stor utsträckning samt att vården av dessa människor är bristfällig på många områden. Bristerna är störst på hemmaplan där samverkan mellan socialtjänst och psykiatri inte på många områden inte fungerar. I undersökningen har vi dock sett positiva förändringar till fungerande samverkan. Denna samverkan kommer förhoppningsvis att fortsätta att utvecklas på fler områden där psykiatri och socialtjänst samt behandlingshem kan samverka. Vi har under arbetets gång vid flera tillfällen beskrivit hur viktigt det är att ha fokus på klientens och den enskilde individens önskningar och målsättningar i behandlingsarbetet. Det vi har gjort i denna undersökning är att se hur samverkan och vården kring klienter med missbruk och psykisk ohälsa ser ut. Vi har även tittat på vilka hinder som finns utifrån psykiatrins, socialtjänstens och behandlingshemmens syn. Vi kan önska att vi i vårt arbete inledningsvis hade haft möjlighet att undersöka klienternas önskningar och åsikter i frågor kring samverkan, utifrån deras upplevelser och uppfattningar. Under uppsatsens arbetsgång har vi också sett att djupa traditionellt bundna olikheter förekommer. Dessa olikheter framträder hos dem som i vardagen arbetar med klienterna/patienterna men också hos dem som styr de olika verksamheterna t ex chefer, politiker och andra beslutfattare.

För att få en helhet och beröra alla områden vore det intressant att i framtiden undersöka vad människor med dubbeldiagnos har för uppfattning om vården. Det vore även intressant att se hur politiker och de styrande inom de olika organisationerna ser på bristerna i den befintliga vården och vilka lösningar man ser på detta växande problem.

Referenslista

- Antonovsky, A. (1991) *Hälsans mysterium*. Stockholm: Natur och Kultur.
- Bryman, A. (2002) *Samhällsvetenskapliga metoder*. Malmö: Liber.
- Croona, G. (2003) *Etik och utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning*. Växjö: Växjö University Press.
- Dobkin, P., De Civita, M., Paraherakis, A., Gill, K. (2002) The role of functional social support in treatment retention and outcomes among outpatient adult substance abusers. *Addiction* vol. 97, Issue 3, p347, 11p.
- Duroy, T., Schmidt, S., Perry, P. (2003) Adolescents' and young adults' perspectives on a continuum of care in a three year drug treatment program. *Journal of drug issues* vol. 33, Issue 4, p801, 32p 1chart, 1diagram.
- Fritzen, L. (1998) *Den pedagogiska praktikens janusansikte. Om det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser*. Lund: Lund University Press.
- Gerdner, A., Sundin Ö. (red) (1998) *Dubbel trubbel. Nya rön och erfarenheter i diagnos och behandling av samtidigt beroende och psykisk störning*. Örebro: Behandlingshemmet Runnagården.
- Hartman, J. (2004) *Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori*. Lund: Studentlitteratur.
- Johansson, K., Wirbing, P. (2001) *Riskbruk och missbruk. Uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri*. Stockholm: Natur och kultur.
- Jansson, I., Fridell, M. (2002) *Psykisk och somatisk belastning hos tvångsvårdade kvinnor. LVM- och LVU-vårdade kvinnor vid Lunden*. Stockholm: Statens institutions styrelse.
- Kvale, S. (1997) *Den kvalitativa forskningsintervjun*. Lund: Studentlitteratur.
- Melin, A-G., Näsholm, C. (1998) *Behandlingsplanering vid missbruk*. Lund: Studentlitteratur.
- Meuser, K.T., Drake, R.E., Wallach, M.A., Kavanagh, D., McFadden M., McHugo, G.J., Bond, G.R., Noordsy, D.L., Fox, L. (2001) *Dubbel diagnos. Allvarlig psykisk sjukdom och missbruk*. Karlskrona: Ett helt liv.
- Palmstierna, T. (2004) *Fokusrapport. Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning och missbruk*. Stockholm: Stockholms läns landsting.
- Pålsson, B. (2005) *Aftonbladet. Jag vill bli drogfri*. Internet: www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,713580,00.html (20 feb 2006)
- von Wright, M. (2003) *Vad eller vem. En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet*. Göteborg: Daidalos.

Watkins, T.R., Lewellen, A., Barett, M.C. (2001) *Dual Diagnosis. An integrated approach to treatment*. California: Sage publications, inc.

Wärmegård, E. (2005) Del av ett sammanhang. Att arbeta med klienters nätverk under och efter LVM. *Allmän SiS -rapport 2005:6*. Internet: www.stat-inst.se/document/2005_6.pdf

Bilaga 1

Antisocial personlighetsstörning

Diagnostiseringskriterier enligt DSM-IV-TR

A. Det finns ett mönster av ringaktning mot andra människor vilket pågått sedan 18 års ålder vilket är indikerat av minst tre (eller fler) av följande:

1. Misslyckande med att följa sociala normer med respekt för lagliga beteenden indikerat av upprepade handlingar som legat till grund för arrestering.
2. Falskhet, indikerat av upprepade lögner, användande av alias eller att ha lurat andra för egen personlig vinnings skull.
3. Impulsivitet eller misslyckande med att planera i förväg.
4. Irritabilitet och aggressivitet indikerat av upprepade slagsmål eller överfall.
5. Vårdslöshet och bristande respekt inför egen och/eller andras säkerhet.
6. Ihärdig vårdslöshet indikerat av upprepade misslyckanden i att ha koncist arbete.
7. Brist på samvete indikerat av bortrationalisering eller oberördhet av att man behandlat någon illa, skadat, eller stulit från någon annan.

B. Individen är minst 18 år (för personer under 18 år se uppförandestörning).

C. Det finns indikatorer för uppförandestörning före 15 års ålder.

D. De antisociala beteendena finns inte exklusivt under schizofreni eller en manisk episod.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisocial_personlighetsst%C3%B6rning)

Bilaga 2

Tillägg i socialtjänstlagen

14 kap 2 §

I sjunde stycket i sekretesslagen har tagits in en bestämmelse om undantag från sekretess, som kan sägas ha till syfte både att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin egen uppgift och att annan vårdmyndighet skall kunna meddela lämplig vård. Uppgiftslämnandet är begränsat till myndighet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bestämmelsen innebär att sekretess inte skall hindra att uppgifter om enskild person eller hans närstående lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd i följande fall:

- När det rör barn eller ungdom, dvs den som inte fyllt 18 år
- När det angår den som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel
- När det gäller gravid kvinna, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.”

Bilaga 3

Intervjuguide

Organisation

Huvudman.

Uppdragsgivare

Struktur. Avdelningar, personal och personalsammansättningar osv.

Utbildning / Kompetens.

Intervjupersonens arbetsuppgifter och yrkeserfarenhet.

Intervjupersonens uppfattningar/upplevelser/erfarenheter av:

Målsättning

Huvudmålsättningar inom områden, socialt/psykiatriskt/fysiskt/beroende.

Övriga målsättningar.

Klienter

Förekomst av dubbla diagnoser.

Förekomst av psykiatriska diagnoser.

Typ av diagnoser.

Missbrukets karaktär / Vanligaste drogval.

Urskiljning av socialgrupper.

Könsskillnader.

Orsaksförklaring

Vad kommer först

I vilken mån påverkar detta er behandling .

Behandling

På vilket sätt arbetar ni praktiskt i verksamheten / Övergripande metod.

Er roll i förändringsprocessen.

Ansvar.

Återfall.

LPT/LVM. Tvångsvård i relation till er verksamhet / generellt.

Vad vore optimal behandling.

Vilka hinder för optimal behandling.

Samverkan

Fördelning av insatser mellan olika organisationer.

Vilka roller har de två övriga aktörerna i förhållande till er och dem i emellan .

Hinder till samarbete (*ekonomi/sekretess/lagstiftning/politik. landsting- kommun osv*).

Vilka möjligheter finns det till integrerade insatser.

Annat som ni vill ta upp?

Bilaga 4

Frågan om medverkan i C-uppsats

Växjö 060207

Hej!

Vi är två studenter som läser inom programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård 120p, vid Växjö universitet.

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal som vi hade den

Vårt intresse och mål med vårt uppsatsarbete är att få en ökad förståelse kring hur arbetet kring missbrukare med psykisk ohälsa bedrivs av tre professionella aktörer, nämligen behandlingshem, psykiatri och socialtjänsten. När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenheter vore intressanta att få ta del av. För att göra detta skulle vi under ett tillfälle vilja intervjua er (intervjun tar ca 1 timme).

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen, vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad gäller uppsatsernas innehåll och etiska aspekter.

Med vänlig hälsning

.....
Peter Fornander

.....
Jonas Jonsson

Handledare:
Stellan Jeppsson

Peter Fornander

Jonas Jonsson